



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KOMUNIKASI EFEKTIF
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Nomor : 823.1/I-PDM/DIR/IX/2025

Tentang

Pedoman Komunikasi Efektif Tahun 2025

Disusun oleh :

Ketua



(drg. Endy Wira Pradana, M.MRS)

Disetujui oleh :

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh :

Direktur RS Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PENGORGANISASIAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah MMRS AFP

PELAKSANA

1. drg. Endy Wira Pradana, M.MRS
2. Mukhammad Eriko Firdaus, S.Kom
3. Mayputri Nabilla, A.Md.Kes
4. Indah Maulhayati, S. Kep. Ns
5. Dyah Kusuma Wardani, Amd. Kep
6. Wibowo Krisdianto, Amd.Kep
7. Ferianto Hendri Cahyono, Amd.Kep
8. Elok Lonchat Okyani, S.Kep.Ns
9. Daning Pravita, S.Tr., Keb
10. Apt. Susanti, S.Farm
11. Rizky Esa Wisnu Wardana, S. Kep. Ns
12. Putri Adi Ramadhanian, Amd. Keb
13. Rista Alfia Sari, Amd. Kep
14. Ni Made Dyah Ayu Sawitri, S. Tr. Kep. Ns
15. Saghita Puspita Sari, Amd. Kep
16. Nafisah Ulfa Hasanah, S. Gz
17. Fitri Octavia, Amd. Kep
18. Mike Maulina, S. Kep. Ns
19. Nabila Riski Amalia, S.Tr. Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Komunikasi Efektif dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS Prima Husada.

Pedoman Komunikasi Efektif ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Malang, 04 September 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
BAB I	13
PENDAHULUAN	13
1.1	8
1.2	9
1.2.1	Error! Bookmark not defined.
1.2.2	9
1.2.3	9
1.2.4	9
1.2.5	Error! Bookmark not defined.
1.2.6	9
1.2.7	Error! Bookmark not defined.
1.2.8.	Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 773.145/I- KEP/DIR/VI/2025 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Malang ;
1.2.9	Error! Bookmark not defined.
1.3	9
1.3.1	10
	Pedoman berkomunikasi efektif sesuai standar di rumah sakit antar sesama PPA, staf rumah sakit dengan pasien, keluarga dan masyarakat. Tujuan komunikasi efektif di Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan pelayanan rumah sakit dan mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan komunikasi efektif yang harus tepat waktu, akurat, lengkap, jelas dan dipahami oleh penerima.
1.3.2	10
1.	10
2.	10
3.	10
4.	10
BAB II	16
TATA LAKSANA KOMUNIKASI EFEKTIF	16
2.1	11
2.1.1	Pelayanan Edukasi di Instalasi Rawat Jalan
2.1.2	Pelayanan Edukasi di Instalasi Rawat Inap
2.1.3	Strategi Dasar Komunikasi Kepada Pasien dan Keluarga serta masyarakat
2.2	17
2.2.1	Peningkatan Komunikasi Efektif, Kompetensi Budaya, dan Asuhan
2.2.2	Tata cara komunikasi disetiap unit yaitu:
2.2.3	Daftar untuk Meningkatkan Komunikasi Efektif, Kompetensi Budaya, dan Asuhan Berfokus Pasien dan Keluarga Selama Penerimaan
2.2.4	Daftar untuk Meningkatkan Komunikasi Efektif, Kompetensi Budaya, dan Pengobatan Terpusat Pasien dan Keluarga Selama Asesmen
2.2.5	Daftar untuk Meningkatkan Komunikasi Efektif, Kompetensi Budaya, dan Pengobatan Terpusat Pasien dan Keluarga Selama Pengobatan.
2.2.6	Melibatkan Pasien dan Keluarga Dalam Proses Pengobatan.
2.2.7	Sesuaikan Proses Arahan Informasi untuk Memenuhi Kebutuhan Pasien.
2.2.8	Memberikan Pendidikan Pasien yang Memenuhi Kebutuhan Pasien.
2.2.9	Mengatasi Kebutuhan Mobilitas Pasien Selama Pengobatan.
2.2.10	Mengakomodasi Budaya, Agama, dan Kegiatan atau Keyakinan Spiritual Pasien.

2.2.11	Memantau Perubahan Kebutuhan Makanan atau Pembatasan yang dapat Mempengaruhi Pengobatan Pasien.	33
2.2.12	Meminta Pasien untuk Memilih Pendamping jika ada yang belum Diidentifikasi.	34
2.2.13	Komunikasikan Informasi tentang Kebutuhan Khusus Pasien pada Tim Asuhan.	34
2.2.14	Daftar untuk Meningkatkan Komunikasi Efektif, Kompetensi Budaya, dan Pengobatan Terpusat Pasien dan Keluarga Selama Pengobatan Akhir	34
2.2.15	Daftar untuk Meningkatkan Komunikasi Efektif, Kompetensi Budaya, dan Pengobatan Terpusat Pasien dan Keluarga Selama Pemulangan dan Transfer.	37
2.2.16	Edukasi Anestesi dan Bedah	39
2.3		36
2.3.1	Komunikasi Efektif Saat Konsul atau Pelaporan Nilai Kritis	41
2.3.2	Timbang Terima (37	
2.3.3	Singkatan Terstandart	42
2.3.4	Alur Pelaporan Untuk Nilai Kritis Dan Diagnostik Kritis	42
	Hasil kritis di definisikan sebagai varian dari rentang normal yang menunjukkan adanya kondisi patologis yang berisiko tinggi atau mengancam nyawa, yang dianggap gawat atau darurat, dan mungkin memerlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kejadian yang tidak diinginkan.	42
2.3.5	Komunikasi Antar Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Dan Staf Klinis	46
2.3.6	Persyaratan Sumber Daya Manusia	50
2.3.7	Penetapan Informasi Tepat Dan Akurat	51
2.3.8	Komunikasi Keluar Rumah Sakit (Rujukan)	53
BAB III		54
	KOMUNIKASI ANTARA PIMPINAN DAN STAF, MANAJEMEN DENGAN UNIT PELAYANAN DAN SEBALIKNYA.	54
3.1		49



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

NOMOR: 823.1/I-PDM/DIR/IX/2025

**TENTANG
PEDOMAN KOMUNIKASI EFEKTIF**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan dan asuhan kepada pasien di Rumah Sakit perlu adanya komunikasi yang efektif.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya Peraturan Direktur tentang Pedoman Komunikasi Efektif
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/SK/Menkes/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN KOMUNIKASI EFEKTIF.**

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Rumah Sakit Prima Husada Malang (RSPHM) adalah Rumah sakit milik PT.Disa Prima Medika, yang beralamatkan di Jalan Banjararum Selatan No.3-7 Singosari - Malang
2. Direktur adalah pimpinan RSPHM yang diangkat oleh PT.Disa Prima Medika bertindak sebagai pejabat pengelola RSPH Malang.
3. Pasien adalah setiap orang yang melaksanakan konsultasi dilema kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
4. Profesional Pemberi Asuhan yang selanjutnya disebut PPA yaitu tenaga-tenaga yang berkewajiban memberikan asuhan meliputi dokter, dokter spesialis, apoteker, dietisien/nutrisionis, perawat, bidan, fisioterapi dan tenaga kesehatan yang lain.
5. Tenaga Kesehatan yakni setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta mempunyai pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melaksanakan upaya kesehatan.
6. Keluarga Pasien adalah setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
7. Pengunjung Rumah Sakit adalah setiap orang yang datang mengunjungi Rumah Sakit untuk kepentingan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan yang lain.
8. Masyarakat Sekitar Rumah Sakit adalah sekumpulan orang yang tinggal dan/atau berinteraksi di area sekitar Rumah Sakit.
9. Komunikasi efektif dalam Promosi Kesehatan Rumah Sakit adalah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui cara/media tertentu sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran (pesan), atau disebut dengan komunikator.
10. *Situation, Background, Assessment, Recommendation* yang selanjutnya disingkat SBAR adalah suatu teknik atau cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi yang cepat dan tepat.
11. Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (*integrated note*) yang selanjutnya disingkat CPPT adalah dokumentasi para profesional pemberi asuhan tentang perkembangan kondisi pasien dalam bentuk terintegrasi pada format baku dalam rekam medis pasien

BAB II KOMUNIKASI EFEKTIF

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit mengatur tata cara berkomunikasi, yang meliputi komunikasi dengan masyarakat, pasien dan keluarga, antar staf klinis/pemberi asuhan Rumah Sakit dalam organisasi Rumah Sakit.
- (2) Komunikasi dilakukan secara tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dapat dipahami oleh para pihak yang terlibat dan berjalan dinamis.
- (3) Sasaran komunikasi efektif adalah pasien, keluarga pasien, pengunjung, masyarakat dan petugas.

Bagian Kesatu
Komunikasi Dengan Masyarakat

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit berkewajiban :memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- (2) Rumah Sakit menggunakan demografi populasi sebagai dasar strategi komunikasi dengan komunitas dan populasi yang menggambarkan usia, etnis, agama, serta tingkat pendidikan termasuk buta huruf dan bahasa yang dipergunakan antara lain hambatan dalam berkomunikasi.
- (3) Rumah sakit menyediakan informasi jenis pelayanan, waktu pelayanan, serta akses dan proses untuk mendapatkan pelayanan.
- (4) Rumah sakit mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang jenis, akses, proses pelayanan di rumah sakit secara berkala.
- (5) Rumah sakit menyediakan informasi kualitas pelayanan
- (6) Rumah sakit berkomunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi akses masyarakat ke pelayanan di rumah sakit dan informasi tentang pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit dalam bentuk *whatsapp, instagram, website* brosur atau *leaflet*.
- (7) Rumah Sakit menyediakan pelayanan dan pendidikan Kesehatan berkelanjutan bagi Warga Lanjut Usia di Masyarakat atau komunitas geriatri berbasis Rumah Sakit (*Hospital Based Community Geriatric Service*)

Pasal 3

Rumah sakit mengidentifikasi sumber-sumber yang ada di komunitas untuk mendukung promosi kesehatan berkelanjutan dan edukasi untuk menunjang asuhan pasien yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Komunikasi Antar Tenaga Kesehatan Pemberi Asuhan di dalam dan Luar Rumah Sakit

Paragraf 1

Komunikasi Efektif Saat Konsul atau Pelaporan Nilai Kritis

Pasal 23

- (1) Menggunakan metode SBAR (*Situation-Background-Assesment-Recommendation*) pada saat konsul atau pelaporan kondisi pasien, pelaporan hasil pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, radiologi dan pemeriksaan yang lain) yang mempunyai nilai kritis dan proses serah terima (hand over).
S. (Situation) : Situasi yang menggambarkan keadaan pasien sehingga perlu dilaporkan.

-
- B. (Background) : Gambaran riwayat atau hal-hal yang mendukung terjadinya kondisi atau situasi pasien saat ini.
- A. (Assesment) : Kesimpulan dari hasil analisa terhadap gambaran situasi dan *background*.
- R. (Recommendation) : Usulan pelapor kepada dokter atau penerima laporan tentang tindakan yang mungkin dilakukan.
- (2) Pemberi pesan secara lisan memberikan pesan, setelah itu dituliskan secara lengkap isi pesan tersebut *Write Back*/ tulis lengkap (disingkat TUL) oleh si penerima pesan.
- (3) Isi pesan dibacakan ulang *Read Back*/ baca ulang (disingkat BA) secara lengkap oleh penerima pesan. Dengan tujuan untuk mengkonfirmasi (disingkat KON) kebenaran perintah atau advis atau terapi.

Paragraf 2
Timbang Terima (*Hand Over*)

Pasal 24

- (1) Hal kritical dikomunikasikan antara profesional pemberi asuhan pada waktu dilakukan serah terima pasien dan dicatat dalam rekam medik
- (2) Formulir, kelengkapan berkas, alat, dan metode ditetapkan untuk mendukung proses serah terima pasien (*hand over*) bila mungkin melibatkan pasien.
- Catatan komunikasi yang terjadi waktu serah terima pasien (*hand over*) dievaluasi untuk memperbaiki proses.

Paragraf 3
Menggunakan Singkatan Terstandar

Pasal 25

Gunakan singkatan yang sudah terstandar di RSPHM. Tulis kata dengan lengkap bila tidak ada dalam daftar singkatan.

Paragraf 4
Pelaporan untuk Nilai Kritis Dan Diagnostik Kritis

Pasal 26

- (1) Rumah sakit menetapkan besaran nilai kritis hasil pemeriksaan diagnostic dan diagnostic kritis.
- (2) Besaran nilai kritis hasil pemeriksaan untuk laboratorium dan radiologi sesuai yang ada dalam lampiran.
- (3) Besaran nilai kritis untuk tanda-tanda vital sesuai dengan yang ada di EWS.
- (4) Yang melaporkan hasil pemeriksaan diagnostic laboratorium yaitu petugas laboratorium.
- (5) Yang melaporkan hasil pemeriksaan diagnostic radiologi yaitu petugas radiologi.

-
- (6) Yang melaporkan hasil pemeriksaan kritis EKG adalah petugas yang melakukan perekaman EKG.
 - (7) Yang menerima laporan nilai kritis hasil pemeriksaan diagnostic adalah PPA dan dilakukan pencatatan di Stempel Nilai Kritis di lembar CPPT.
 - (8) Hasil pemeriksaan diagnostic nilai kritis yang sudah tertulis harus segera dilaporkan ke DPJP maksimal 30 menit sejak hasil keluar dan disetujui dokter spesialis patologi klinis sampai DPJP memberikan advis.

Terkait hasil pemeriksaan diagnostic nilai kritis yang sudah tertulis di rekam medis harus segera dilaporkan kepada DPJP (dokter Penanggung Jawab Pasien) maksimal 30 (Tiga Puluh menit) sejak hasil keluar & disetujui dokter spesialis patologi klinis sampai DPJP memberikan ADVIS.

Paragraf 5

Komunikasi antar profesional pemberi asuhan (PPA) dan staf klinis

Pasal 27

Komunikasi Antar Profesional pemberi Asuhan (PPA)

- (1) Komunikasi efektif dilakukan antar profesional pemberi asuhan
- (2) Komunikasi efektif yang dimaksud adalah komunikasi secara langsung atau melalui telepon
- (3) Pesan secara verbal melalui telepon ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima pesan dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan dengan metode SBAR.
- (4) Penyampaian hasil pemeriksaan diagnostik secara verbal ditulis lengkap, dibaca ulang, dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan secara lengkap (TULBAKON).
- (5) Bukti pelaksanaan komunikasi efektif antar staf klinis dalam rekam medis meliputi CPPT, transfer antar unit, rujukan, *early warning system* (EWS), tulis baca konfirmasi (tulbakon), serah terima (operan)/*hand over*.

Pasal 28

Komunikasi antar staf klinis

- (1) Komunikasi antar staf klinis pada saat bekerja shift dan antar shift yang meliputi informasi tentang:
 - a. status kesehatan termasuk catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) ;
 - c. ringkasan pasien rawat jalan yang disebut dengan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) dibuat sebagai ringkasan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter selama masa perawatan atau saat pasien berada di klinik rawat jalan;
 - d. ringkasan pasien pulang rawat inap didokumentasikan di E-rekam medis;
 - c. informasi klinis saat transfer dan dirujuk; dan
 - d. serah terima/operan/*hand over*, dicatat dalam E-rekam medis.
- (2) Informasi kondisi pasien antar staf klinis termasuk PPA pada saat penting atau tertentu dalam proses asuhan ditulis dalam E-Rekam Medis.

-
- (3) Setiap pasien rawat inap yang sudah direncanakan akan Keluar Rumah Sakit (KRS) harus ditulis dalam E-Rekam Medis (ringkasan pulang).
 - (4) Setiap pasien rawat inap yang sudah Keluar Rumah Sakit (KRS) dalam waktu kurang dari 24 jam harus dibuat Ringkasan Pasien Pulang ditulis di E-Rekam Medis.
 - (5) Setiap pasien rawat jalan dengan diagnosis kompleks dibuat resum ringkasan medis rawat jalan yang sudah dimasukkan di E-Rekam Medis.
 - (6) Proses transfer dan rujukan dalam E-rekam medis memuat informasi yang dikomunikasikan termasuk ringkasan asuhan dan pelayanan yang telah diberikan.
 - (7) Dokumentasi proses serah terima pasien/operan dalam shift (*hand over*) tercatat dalam rekam medis.

Paragraf 6

Persyaratan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasal 29

- (1) PPA dan staf klinis terlatih komunikasi efektif dan Eduktor .
- (2) Staf Non Klinis terlatih komunikasi efektif

Paragraf 7

Penetapan Informasi Tepat Dan Akurat

Pasal 30

- (1) Penetapan informasi yang harus disampaikan secara akurat dan tepat waktu ke seluruh rumah sakit.
- (2) Penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu di seluruh rumah sakit termasuk yang urgent antara lain *code blue* dan *code red*.

Paragraf 8

Komunikasi Keluar Rumah Sakit (Rujukan)

Pasal 31

- (1) Rumah Sakit melalui staf klinis yang kompeten melaksanakan Komunikasi kepada RS rujukan yang telah bekerjasama dengan RSPHM dan memastikan ketersediaan pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien.
- (2) Dokumentasi proses serah terima pasien yang dirujuk tercatat dalam Form Rujukan dan dievaluasi untuk perbaikan.

BAB III

KOMUNIKASI ANTARA PIMPINAN DAN STAF, MANAJEMEN DENGAN UNIT PELAYANAN DAN SEBALIKNYA.

Pasal 32

- (1) Rumah Sakit melaksanakan Komunikasi antara pimpinan dan staf, manajemen dengan unit pelayanan dan sebaliknya.

-
- (2) Komunikasi efektif yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat atau melalui media komunikasi elektronik.
 - (3) Rapat dilaksanakan baik internal maupun lintas program dan lintas sektor yang dipimpin oleh pimpinan rapat yang kompeten dalam komunikasi efektif .
 - (4) Pengaturan lebih lanjut tentang rapat diatur tersendiri dalam peraturan direktur.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Rumah Sakit melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap program dari masing-masing bagian.
- (2) Monitoring dan evaluasi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan bulanan, tri bulanan, dan tahunan.

BAB V PENUTUP

Pasal 34

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang komunikasi efektif tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan direktur ini
- (2) Peraturan Direktur RS Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 September 2025
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RS PRIMA
HUSADA NOMOR : 823.1/I-PDM/DIR/IX/2025
TENTANG PEDOMAN KOMUNIKASI EFEKTIF

PEDOMAN KOMUNIKASI EFEKTIF

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sejahtera, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009, merupakan penyesuaian dari SKN 2004, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009, dinyatakan bahwa salah satu subsistem dari SKN adalah subsistem upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan salah satu unsur dalam subsistem upaya kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah Pelayanan Kesehatan meliputi peningkatan pencegahan, pengobatan dan pemulihan, baik pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan kesehatan yang terdiri dari pengobatan tradisional dan komplementer melalui pendidikan dan pelatihan dengan selalu mengutamakan keamanan dan efektifitas yang tinggi. Upaya kesehatan diutamakan pada berbagai upaya yang mempunyai daya ungkit tinggi dalam pencapaian sasaran pembangunan kesehatan utamanya penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut, dan keluarga miskin.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan pengertian rumah sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selanjutnya dikatakan bahwa Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Efektifitas suatu pengobatan selain dipengaruhi oleh pola pelayanan kesehatan yang ada serta sikap dan keterampilan para pelaksananya, juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sikap, pola hidup pasien, dan keluarganya. Kalau pasien dan keluarga memiliki pengetahuan tentang cara – cara penyembuhan dan pencegahan penyakitnya, serta keluarga pasien mampu dan mau berpartisipasi secara positif, maka hal ini akan membantu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya.

Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) berusaha mengembangkan pengertian pasien, keluarga dan pengunjung rumah sakit tentang penyakit dan pencegahannya. Selain itu PKRS juga berusaha menggugah kesadaran dan minat pasien, keluarga dan pengunjung rumah sakit untuk berperan secara positif dalam berusaha penyembuhan dan pencegahan penyakit. Oleh karena itu, PKRS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pelayanan kesehatan rumah sakit.

Memberikan asuhan pasien merupakan upaya yang kompleks dan sangat bergantung pada komunikasi dari informasi. Komunikasi tersebut adalah kepada dan dengan komunitas, pasien

dan keluarganya, serta antara staf klinis, terutama Profesional Pemberi Asuhan (PPA). Kegagalan dalam berkomunikasi merupakan salah satu akar masalah yang paling sering menyebabkan insiden keselamatan pasien. Komunikasi dapat efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan/komunikator, pesan ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan oleh penerima pesan/komunikator, dan tidak ada hambatan untuk hal itu.

Komunikasi efektif sebagai dasar untuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga agar mereka memahami kondisi kesehatannya sehingga pasien berpartisipasi lebih baik dalam asuhan yang diberikan dan mendapat informasi dalam mengambil keputusan tentang asuhannya.

Edukasi kepada pasien dan keluarga diberikan oleh staf klinis terutama PPA yang sudah terlatih (dokter, perawat, nutrisionis, apoteker, dll). Mengingat banyak profesi yang terlibat dalam edukasi pasien dan keluarganya maka perlu koordinasi kegiatan dan fokus pada kebutuhan edukasi pasien.

Edukasi yang efektif diawali dengan asesmen kebutuhan edukasi pasien dan keluarganya. Asesmen ini menentukan bukan hanya kebutuhan akan pembelajaran, tetapi juga proses edukasi dapat dilaksanakan dengan baik. Edukasi paling efektif apabila sesuai dengan pilihan pembelajaran yang tepat dan mempertimbangkan agama, nilai budaya, juga kemampuan membaca serta Bahasa. Edukasi akan berdampak positif bila diberikan selama proses asuhan.

Edukasi termasuk pengetahuan yang diperlukan selama proses asuhan maupun pengetahuan yang dibutuhkan setelah pasien dipulangkan (*discharged*) ke pelayanan kesehatan lain atau ke rumah. Dengan demikian, edukasi dapat mencakup informasi sumber-sumber di komunitas untuk tambahan pelayanan dan tindak lanjut pelayanan apabila diperlukan, serta bagaimana akses ke pelayanan emergensi bila dibutuhkan. Edukasi yang efektif dalam suatu rumah sakit hendaknya menggunakan format visual dan elektronik, serta berbagai edukasi jarak jauh dan teknik lainnya.

1.2 Dasar Hukum

- 1.2.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan;
- 1.2.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 1.2.3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
- 1.2.4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
- 1.2.5 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
- 1.2.6 Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 263//DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
- 1.2.7 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit
- 1.2.8 Asas keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

1.3 Tujuan Pedoman

1.3.1 Tujuan Umum

Pedoman berkomunikasi efektif sesuai standar di rumah sakit antar sesama PPA, staf rumah sakit dengan pasien, keluarga dan masyarakat. Tujuan komunikasi efektif di Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan pelayanan rumah sakit dan mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan komunikasi efektif yang harus tepat waktu, akurat, lengkap, jelas dan dipahami oleh penerima.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Meningkatkan kualitas pelayanan medis dengan memberikan informasi medis yang selektif, terpercaya dan menyeluruh kepada setiap pasien dan keluarganya yang datang ke rumah sakit
2. Menyediakan informasi yang dibutuhkan pasien maupun keluarganya seperti rencana promotif, diagnosis kerja, rencana diagnostik, rencana terapi, prognosis, rencana rehabilitatif dan rencana preventif.
3. Menyempurnakan sistem kerja Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Prima Husada demi peningkatan pelayanan bagi masyarakat.
4. Mensukseskan program pemerintah dalam bidang kesehatan dan promosi kesehatan khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan sistem kesehatan nasional.

BAB II

TATA LAKSANA KOMUNIKASI EFEKTIF

Komunikasi dapat berbentuk verbal, elektronik, atau tertulis. Komunikasi yang jelek dapat membahayakan pasien. Komunikasi yang rentan terjadi kesalahan adalah saat perintah lisan atau perintah melalui telepon, komunikasi verbal, saat menyampaikan hasil pemeriksaan kritis yang harus disampaikan lewat telepon. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan aksen dan dialek. Pengucapan juga dapat menyulitkan penerima perintah untuk memahami perintah yang diberikan. Misalnya, nama-nama obat yang rupa dan ucapannya mirip (*look alike, soundalike*), seperti phenobarbital dan pentobarbital, serta lainnya. Pelaporan hasil pemeriksaan diagnostik kritis juga merupakan salah satu isu keselamatan pasien.

Untuk melakukan komunikasi secara verbal atau melalui telepon dengan aman dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemesananan obat atau permintaan obat secara verbal sebaiknya dihindari
2. Dalam keadaan darurat karena komunikasi secara tertulis atau komunikasi elektronik tidak mungkin dilakukan maka harus ditetapkan panduannya meliputi permintaan pemeriksaan, penerimaan hasil pemeriksaan dalam keadaan darurat, identifikasi dan penetapan nilai kritis, hasil pemeriksaan diagnostik, serta kepada siapa dan oleh siapa hasil pemeriksaan kritis dilaporkan
3. Prosedur menerima perintah lisan atau lewat telepon meliputi penulisan secara lengkap permintaan atau hasil pemeriksaan oleh penerima informasi, penerima membaca kembali permintaan atau hasil pemeriksaan, dan pengirim memberi konfirmasi atas apa yang telah ditulis secara akurat

Penggunaan singkatan-singkatan yang tidak ditetapkan oleh rumah sakit seringkali menimbulkan kesalahan komunikasi dan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, rumah sakit diminta memiliki daftar singkatan yang diperkenankan dan dilarang. Serah terima asuhan pasien (*hand over*) di dalam rumah sakit terjadi :

1. Antar-PPA seperti antara staf medis dan staf medis, antara staf medis dan staf keperawatan atau dengan staf klinis lainnya, atau antara PPA dan PPA lainnya pada saat pertukaran shift
2. Antar berbagai tingkat layanan di dalam rumah sakit yang sama seperti jika pasien dipindah dari unit intensif ke unit perawatan atau dari unit darurat ke kamar operasi
3. Unit rawat inap ke unit layanan diagnostik atau unit tindakan seperti radiologi atau unit terapi fisik.

Gangguan komunikasi dapat terjadi saat dilakukan serah terima asuhan pasien yang dapat berakibat kejadian yang tidak diharapkan (*adverse event*) atau kejadian sentinel. Komunikasi yang baik dan terstandar baik dengan pasien, keluarga pasien, dan pemberi layanan dapat memperbaiki secara signifikan proses asuhan pasien.

2.1 Komunikasi Dengan Masyarakat

Rumah sakit berkomunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi akses masyarakat ke pelayanan di rumah sakit dan informasi tentang pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit. Rumah sakit mengenali komunitas dan populasi pasiennya, serta merencanakan komunikasi berkelanjutan dengan kelompok kunci (*keygroup*) tersebut. Komunikasi dapat dilakukan kepada individu secara langsung atau melalui media publik dan agen yang ada di komunitas atau pihak ketiga melalui komunikasi efektif.

Tujuan komunikasi efektif dengan masyarakat adalah memfasilitasi akses masyarakat ke pelayanan di rumah sakit. Dalam memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit maka rumah sakit juga harus mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan komunikasi efektif pada pasien dan keluarga. Komunikasi efektif harus tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh penerima. Komunikasi dengan masyarakat terbagi menjadi dua tempat yaitu di

dalam gedung dan di luar gedung. Berikut tempat dan kegiatan yang dilakukan di dalam gedung (Tabel 2.1).

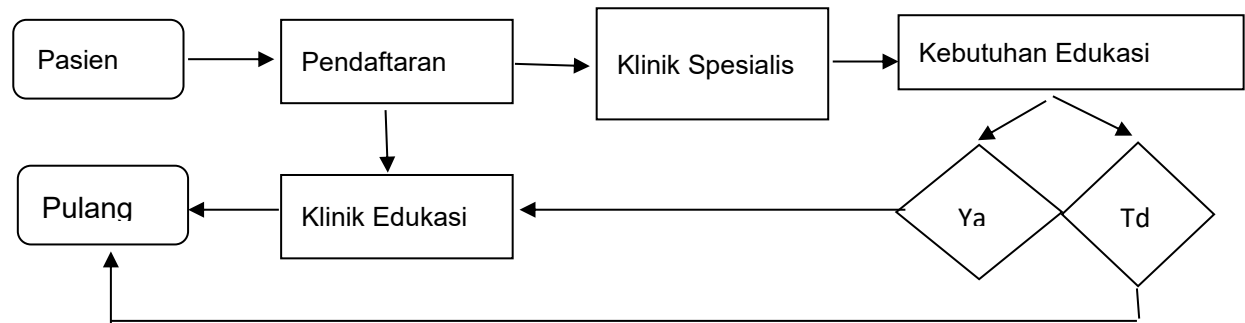
Tabel 2.1 Komunikasi Dengan Pasien Dan Keluarga Juga Masyarakat Di Dalam Gedung

NO	TEMPAT	KETERANGAN
1.	Pendaftaran/ admisi	a. Pasien/klien mendaftar sebelum mendapatkan pelayanan rumah sakit, dengan mengambil nomor antrian jika merupakan pasien BPJS dan atau memberikan identitas pasien sekaligus pemberian informasi kelengkapan persyaratan. b. Petugas pendaftaran mendaftar pasien sekaligus memberikan informasi jenis dan akses untuk mendapatkan pelayanan , jam buka , nama spesialis dan kompetensinya yang ada di RS Prima Husada Malang . Contoh : pendaftaran via aplikasi media sosial whatsapp khusus pada pasien rawat jalan poli spesialis atau secara datang langsung. c. Menempatkan leaflet tentang informasi jenis dan akses pelayanan di tempat yang sudah disediakan dan boleh diambil secara gratis. d. Rumah sakit memiliki ruang tunggu yang dilengkapi media televisi untuk menayangkan berbagai edukasi atau pesan kesehatan dalam bentuk video dari USB . e. Memberikan edukasi hak, kewajiban dan tata tertib kepada pasien dan keluarga khususnya yang akan rawat inap.
2.	Pelayanan rawat jalan	a. Petugas /PPA memberikan intervensi PKRS berupa edukasi sesuai asesmen kebutuhan dan perencanaan edukasi dan bukti leaflet jika diperlukan di semua Poli Rawat Jalan. b. PPA sebagai edukator telah memiliki sertifikat pelatihan komunikasi efektif, c. Edukasi menggunakan berbagai metode dan media yang sesuai kebutuhan misalnya leaflet, lembar balik, poster, gambar atau model/alat peraga, dan tayangan menggunakan audiovisual, laptop dan LCD. Contoh : Bila ada seorang pasien yang hendak dioperasi katarak, mungkin menginginkan penjelasan tentang proses operasi katarak tersebut. Selain penjelasan lisan, PPA akan menyajikan gambar-gambar tentang proses operasi tersebut.
3.	Pelayanan rawat inap	a. Memberikan intervensi PKRS di rawat intensif dan rawat inap secara individu kepada pasien dan keluarga. (Bisa dilakukan saat PPA visite). b. Memberikan intervensi secara kelompok kepada keluarga yang menunggu pasien untuk materi-materi umum, bertempat di ruang tunggu keluarga pasien. c. Sebagai bukti pemberian edukasi maka tanda tangan edukator dan komunikan tertera dalam RM d. PPA memberikan waktu yang cukup adekuat untuk memberikan edukasi. e. Keyakinan / kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini pasien dan keluarga wajib dihormati dan pelayanan diberikan sesuai keyakinan dan kepercayaannya. f. Pendekatan agama dilakukan oleh PPA sesuai keyakinan masing-masing, yang bisa diminta kepada petugas utamanya

NO	TEMPAT	KETERANGAN
		pendampingan oleh Rohaniawan baik dalam keadaan sakit ataupun pasien terminal (menjelang ajal).
4.	Pelayanan penunjang medik	a. Pelayanan obat/apotek, pelayanan Gizi, laboratorium, radiologi dan pelayanan rehabilitasi medik, wajib memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. b. PPA di depo Farmasi wajib memberikan edukasi tentang obat, dosis, efek obat, efek samping, penyimpanan, peringatan pemakaian dan interaksi obat dg makanan. Sambil menunggu obat disiapkan, pasien bisa mengambil leaflet yang telah disediakan di Pelayanan Farmasi (Yanfar) secara gratis, TV di depan apotek bisa digunakan sebagai media promosi pelayanan/kesehatan yang ada di RS c. Petugas di laboratorium dan Radiologi memberikan edukasi tentang manfaat pemeriksaan yang akan dilakukan, bahaya dan efek samping dan wajib melakukan edukasi melalui poster yang ditempel di dinding atau penyediaan leaflet atau brosur, dapat diambil gratis.
5.	Pelayanan bagi klien (orang sehat)	a. PPA memberikan intervensi PKRS dengan cara pemberian edukasi dan membagikan leaflet kepada pengunjung, keluarga atau pengantar misal : pelayanan KB, gizi, penyakit, b. Rumah sakit mempunyai kegiatan pengajian/ tausiyah minggu kedua dan keempat setiap bulannya bertempat di Masjid Baiturrahim RS Prima Husada Khusus Kegiatan berhubungan dengan Geriatri (Komunitas Geriatri RS Prima Husada – KGPH) c. Rumah sakit mempunyai kegiatan pembinaan Komunitas berbasis RSPH Malang 1). PONE (DOLINA Senam Hamil), 2) HIV 3) Stunting dan Wasting 4. Keluarga Berencana Rumah Sakit (KABERUSA) 5) TB DOTS 6) dll.
6.	Ruang pelayanan rawat inap sebelum pulang Khususnya pasien dengan penyakit kompleks	a. PPA/edukator menyiapkan pasien dan keluarga serta memberikan bekal edukasi dan keterampilan dalam kelanjutan perawatan di rumah leaflet tentang pelayanan yang tersedia dan untuk kontrol kembali di rumah sakit. b. Edukasi kepada keluarga untuk kemandirian pasien di rumah baik dalam hal nutrisi, obat, latihan gerak, perawatan yang lain dan jika perlu tawarkan <i>home care</i>. c. Untuk mempercepat kesembuhan pasien di rumah dengan diberikan rujukan edukasi ke komunitas, Fasyankes pertama di sekitar rumah mereka sesaat sebelum pasien pulang dalam upaya pendidikan pasien berkelanjutan d. Pasien rawat inap harus menyelesaikan pembayaran biaya rawat inap jika bukan pasien dengan jaminan, sebelum meninggalkan rumah sakit, yang sebelumnya diberikan edukasi oleh petugas tentang perkiraan biaya. e. Petugas bagian pendaftaran melakukan cetak surat control dan memberikan penjelasan terkait kontrol dan juga menyampaikan salam hangat dan ucapan semoga lekas sembuh, selamat jalan, semoga semakin bertambah sehat, bila kelak pasien membutuhkan pertolongan mendadak , dipersilahkan untuk datang lagi ke RS Prima Husada Malang melalui IGD baik langsung ataupun melalui online.

2.1.1 Pelayanan Edukasi di Instalasi Rawat Jalan

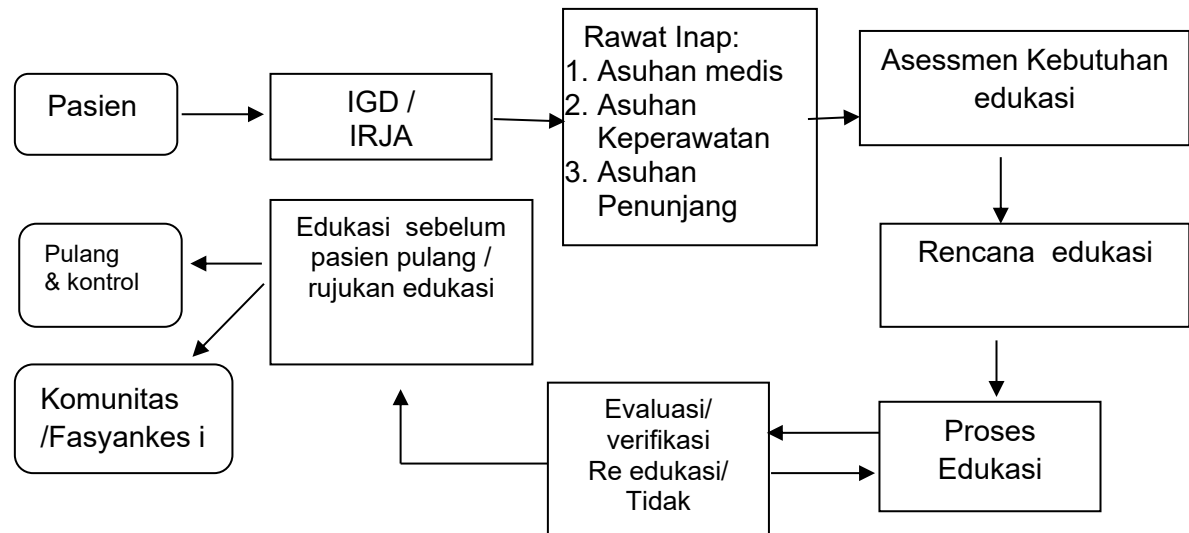
Gambar 2.1 Alur pelayanan edukasi di Instalasi rawat jalan digambarkan pada bagan berikut



Gambar 2.1 Alur Pelayanan Edukasi Rawat Jalan

2.1.2 Pelayanan Edukasi di Instalasi Rawat Inap

Gambar 2.2 Alur pelayanan edukasi di Instalasi rawat inap digambarkan pada bagan berikut



Gambar 2.2 Alur Pelayanan Edukasi Rawat Inap

Tabel 2.2 Komunikasi dengan Masyarakat di Luar Gedung

No.	Tempat	Penerapan Komunikasi yang Dilakukan
1.	Tempat Parkir	a. Memasang spanduk/Banner/ Papanisasi tentang Edukasi dan Informasi kesehatan seperti larangan merokok sesuai UU Kesehatan, tentang peringatan hari kesehatan, pelayanan rumah sakit, kegiatan-kegiatan sosial b. Memasang banner atau baliho tentang himbauan kesehatan atau pelayanan rumah sakit c. <i>Sign box</i> dan <i>neon box</i> . Contoh : pelayanan UGD 24 jam dengan <i>trauma center</i> Best, jenis klinik spesialis, pelayanan rumah sakit, dan lain-lain.
2.	Taman rumah sakit	
3.	Dinding luar rumah sakit	
4.	Tempat umum di lingkungan rumah sakit	

5.	Pagar pembatas kawasan rumah sakit.	
----	-------------------------------------	--

2.1.3 Strategi Dasar Komunikasi Kepada Pasien dan Keluarga serta masyarakat

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah ujung tombak dari upaya promosi Kesehatan di rumah sakit. Pada hakikatnya pemberdayaan adalah upaya membantu atau memfasilitasi pasien/klien, sehingga memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk mencegah dan atau mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya. Karena itu, pemberdayaan hanya dapat dilakukan terhadap pasien/klien. Berikut upaya yang dilakukan di instalasi rawat jalan dan rawat inap dijelaskan pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Pemberdayaan Pasien dan Keluarga

Tempat Pemberdayaan	Penerapan Pemberdayaan Pasien
Rawat Jalan	1. PPA memberikan konseling mereka yang menderita suatu penyakit. Contoh :konseling diabetes mellitus, dislipidemia, jantung dan lain-lain. 2. PPA memberikan konseling ntuk mereka yang sehat. Contoh : konseling gizi, konseling KB. Bagi klien yang sehat dapat pula dibuka kelompok-kelompok diskusi, kelompok-kelompok senam, kelompok-kelompok paduan suara, keterampilan lansia dan lain-lain.
Rawat Inap	1. Konseling di tempat tidur (<i>bedside health promotion</i>) oleh PPA 2. PPA membentuk kelompok untuk diberikan konseling (untuk penderita yang dapat meninggalkan tempat tidur). 3. PPA mendatangi pasien memberikan edukasi dan melatih keterampilan untuk kepentingan pasien sehingga keluarga dapat melakukan perawatan sendiri.

Dengan pemberdayaan diharapkan pasien berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau, dan dari mau menjadi mampu untuk melaksanakan perilaku-perilaku yang dikehendaki guna mengatasi masalah kesehatannya.

b. Bina Suasana

Pemberdayaan akan lebih cepat berhasil bila didukung dengan kegiatan menciptakan suasana atau lingkungan yang kondusif. Tentu saja lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang diperhitungkan memiliki pengaruh terhadap pasien yang sedang diberdayakan. Kegiatan menciptakan suasana atau lingkungan yang kondusif ini disebut bina suasana.

Tabel 2.4 Bina Suasana

Jenis Klien	Sasaran	Penerapan Bina Suasana
Pasien rawat jalan (orang yang sakit)	Lingkungan yang berpengaruh adalah keluarga atau orang yang membiayai atau	a. PPA melakukan pendekatan kepada orang atau keluarga yang berpengaruh pada pasien sehingga dapat mempengaruhi pasien , misalnya PPA memberikan edukasi tentang Pencegahan suatu penyakit terkait dengan perubahan pola makan dan gaya hidup serta

Jenis Klien	Sasaran	Penerapan Bina Suasana
	mengantarkannya ke rumah sakit juga yang membantu merawat di rumah.	pola pikir, kepada keluarga yang mempunyai pengaruh besar kepada pasien untuk mendukung kesembuhan pasien. b. Rumah sakit menyediakan media dan metode sesuai kemampuan belajar pasien dan keterampilan khusus sebagai edukator kepada PPA agar dapat mensugesti pasien dan keluarga c. Membuat suasana RS sebagai tempat belajar dengan banyak terpasang nya poster, leaflet, atau televisi yang dirancang untuk secara terus menerus menayangkan informasi tentang kesehatan
Klien rawat jalan (orang yang sehat)	Lingkungan yang berpengaruh terutama adalah para petugas rumah sakit yang melayaninya	Petugas yang ramah dan sabar serta perhatian akan membuat pasien dan keluarga mantap menyerahkan kesembuhannya di RS ini
Pengantar pasien	Penggunaan media	PPA membagikan selebaran (leaflet), pemasangan fan poster, atau penayangan video berkaitan dengan penyakit dari pasien sehingga pengantar bila mempunyai keluarga yang menderita penyakit tersebut bisa membantu untuk memberikan edukasi
Klien yang sehat	Yang berkunjung ke klinik-klinik konseling atau ke kelompok senam, petugas-petugas rumah sakit yang melayani mereka sangat kuat pengaruhnya sebagai panutan.	PPA memberikan penyuluhan misalnya teladan tidak merokok, tidak sembarangan meludah tidak membuang sampah sembarangan, menjadikan klien yang sehat sebagai panutan untuk hidup sehat dan lain sebagainya.
Pasien rawat inap	Lingkungan yang berpengaruh terutama adalah para penjenguk	a. PPA membagikan selebaran dan pemasangan poster yang sesuai dengan penyakit pasien yang akan mereka jenguk. b. PPA mengumpulkan penjenguk pasien yang sama penyakitnya dalam satu ruangan dengan santai dan penuh persahabatan untuk mendapat edukasi kelompok dan

Jenis Klien	Sasaran	Penerapan Bina Suasana
	pasien (pembesuk).	berdiskusi dengan dokter atau PPA yang lain.

c. Advokasi

Rumah sakit melakukan advokasi dalam upaya memberdayakan pasien dan klien, rumah sakit yang membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain. Misalnya dalam rangka mengupayakan lingkungan rumah sakit tanpa asap rokok, rumah sakit melakukan advokasi kepada wakil-wakil rakyat dan pimpinan daerah untuk diterbitkannya peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di rumah sakit. Sasaran advokasi hendaknya diarahkan/dipandu untuk menempuh tahapan sebagai berikut :

1. Memahami/menyadari persoalan yang diajukan
2. Tertarik untuk ikut berperan dalam persoalan yang diajukan
3. Mempertimbangkan sejumlah pilihan kemungkinan dalam berperan
4. Menyepakati satu pilihan kemungkinan dalam berperan
5. Menyampaikan langkah tindak lanjut

2.2 Komunikasi Dengan Pasien Dan Keluarga

2.2.1 Peningkatan Komunikasi Efektif, Kompetensi Budaya, dan Asuhan

Meningkatkan komunikasi efektif, kompetensi budaya, dan asuhan berfokus pasien dan keluarga selama penerimaan dengan cara yaitu:

1. Rumah sakit memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang jenis asuhan dan pelayanan, proses layanan serta akses untuk mendapatkan pelayanan.
2. Komunikasi dan edukasi kepada keluarga diberikan dalam format serta Bahasa yang mudah dimengerti
3. Menginformasikan pasien tentang hak-hak dan kewajiban mereka. Mengenali bahasa pilihan pasien untuk mendiskusikan rencana perawatan kesehatan.
4. Mengenali apakah pasien memiliki kebutuhan sensorik atau komunikasi. Tentukan apakah pasien perlu bantuan mengisi formulir pendaftaran.
5. Kumpulkan data ras dan etnis pasien dalam catatan medis. Mengenali jika pasien menggunakan perangkat bantu.
6. Menanyakan pasien jika ada kebutuhan tambahan yang dapat mempengaruhi perawatannya.
7. Komunikasikan informasi tentang kebutuhan pasien khusus untuk tim asuhan. Mengajak keluarga berpartisipasi dalam membuat keputusan pada proses asuhan.

2.2.2 Tata cara komunikasi di setiap unit yaitu:

1. Pendaftaran Pasien
 - a. Petugas pendaftaran memberikan salam hangat kepada pasien dan keluarga yang datang.
 - b. Petugas pendaftaran mewawancarai pasien dan keluarga pasien terhadap identitas pasien.
 - c. Untuk data nama pasien dilakukan eja huruf oleh pasien dan keluarga atau diulang oleh petugas pendaftaran dengan mengeja huruf sehingga tidak terjadi kesalahan nama pasien.
 - d. Untuk data tanggal lahir/ umur, petugas mengulang menanyakan kebenaran data dan apabila masih diragukan maka pengecekan langsung ke unit terkait untuk memastikan kesesuaian umur dengan fisik pasien.
2. Pendaftaran Pasien Rawat Inap

-
- a. Pasien dan keluarga datang ke bagian pendaftaran rawat inap untuk melakukan pendaftaran rawat inap.
 - b. Petugas pendaftaran memberikan informasi tentang Hak dan kewajiban pasien, Tata Tertib, Identifikasi pasien, Jenis pelayanan, Fasilitas ruangan/ pelayanan, Tarif ruangan, Tarif tindakan, Pasien atau keluarga dijelaskan tentang isi dari general consent satu persatu sampai tuntas.
 - c. Petugas menuliskan isi penjelasan di atas pada rekam medis dan apabila hal-hal yang dijelaskan sudah dimengerti dan disetujui oleh pasien dan keluarga maka dokumen rekam medis ditandatangani oleh pasien dan keluarga dan petugas pendaftaran yang memberikan informasi.
 - d. Setelah pasien setuju dengan informasi biaya dan tindakan medis, petugas pendaftaran menginformasikan ke unit terkait.
 - e. Jika pasien tidak setuju dengan informasi biaya, petugas pendaftaran akan menginformasikan kepada MPP tentang solusi yang akan diberikan.
 - f. Jika terjadi perubahan, petugas pendaftaran akan menginformasikan kepada keluarga pasien.
3. Komunikasi Dokter IGD dengan Pasien dan Keluarga
- a. Dokter memperkenalkan diri dan memberi salam kepada pasien dan keluarga
 - b. Setelah dilakukan pemeriksaan (anamnesis, fisik) kemudian dokter menjelaskan diagnosis atau perkiraan diagnosis pasien, serta pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan kemudian menuliskan pada rekam medis IGD.
 - c. Dokter menjelaskan tujuan pemeriksaan, hasil yang diharapkan dari pemeriksaan penunjang tersebut untuk menegakkan diagnosis.
 - d. Untuk besarnya biaya pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan, pasien dan keluarga diminta ke pendaftaran/kasir untuk mendapatkan penjelasan atau informasi.
 - e. Apabila pasien atau keluarga setuju, pemeriksaan dapat dikerjakan setelah menyelesaikan administrasi pembayaran.
 - f. Apabila pasien atau keluarga tidak setuju, maka pemeriksaan tidak dilakukan dan keluarga atau pasien menandatangani form penolakan tindakan setelah menerima edukasi dari petugas, dan juga dilanjutkan dengan edukasi kemungkinan yang terjadi jika tidak dilakukan pemeriksaan tsb.
 - g. Setelah hasil pemeriksaan penunjang sudah selesai, kemudian dokter menjelaskan ke pasien atau keluarga pasien.
 - h. Bila pasien akan direncanakan rawat inap, pengambilan sampel darah untuk laboratorium akan dilakukan saat pasien dipasang infus.
 - i. Bila pasien stabil dan siap untuk dipindah maka dokter akan memberikan *advice* kepada *helper* dan perawat untuk memindahkan pasien beserta rekam medisnya.
4. Komunikasi Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dengan Pasien dan Keluarga
- a. DPJP wajib memberikan edukasi kepada pasien tentang informasi yang benar, jelas dan jujur.
 - b. DPJP mengetahui kewajiban dan tanggung jawab terhadap pasien dan keluarga.
 - c. DPJP mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti.
 - d. DPJP memahami konsekuensi pelayanan.
 - e. DPJP wajib mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit.
 - f. DPJP memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa.
 - g. DPJP wajib menyediakan waktu yang cukup untuk memberikan edukasi.
 - h. Edukasi informasi diagnosis, tindakan dan terapi secara lisan dan dicatat dalam form penunjukkan DPJP utama dan bukti pelaksanaan penjelasan DPJP dilengkapi dengan tanda tangan pasien dan DPJP.
 - i. DPJP wajib membuat rencana pelayanan
 - 1) Dokter menuliskan rencana kerja atau permasalahan medis yang akan ditangani.

- 2) Dokter menulis rencana tindakan yang akan dilakukan, dapat berupa rencana pemeriksaan penunjang, konsul, dan lain-lain.
- 3) Dokter menyusun rencana terapi atau intervensi guna menangani masalah.
- 4) Dokter membubuhkan tanda tangan dan waktu penulisan pada setiap form rekam medis
- j. DPJP menginformasikan rencana pelayanan terhadap pasien atau keluarga
 - 1) Dokter menyampaikan pada pasien bahwa pasien diperiksa dan dibuat diagnosis kerja.
 - 2) Dokter menyampaikan pada pasien tentang pemeriksaan/ tindakan apa yang akan dilaksanakan.
 - 3) Dokter memberikan edukasi bila akan dilakukan tindakan invasif (misal : pembedahan atau anestesi) pasien atau keluarga wajib mengisi form informed consent yang didokumentasikan pada rekam medis.
 - 4) Dokter menjelaskan kemungkinan manfaat dan resiko terhadap tindakan.
 - 5) Dokter memastikan apakah pasien/keluarga sudah paham.
 - 6) Dokter mempersilahkan pasien untuk menanyakan sesuatu apabila belum jelas.
 - 7) Dokter menuliskan pada dokumen rekam medis bahwa telah menginformasikan rencana pelayanan dan membubuhkan paraf.
 - 8) Dokter membuat ringkasan pulang saat pasien akan KRS.
5. Komunikasi Perawat dengan Pasien dan Keluarga
 - a. Memberi salam pada pasien dan keluarga.
 - b. Mengecek kembali gelang pasien dan gelang alergi.
 - c. Menjelaskan kepada pasien dan keluarga tentang orientasi ruangan yang berisi fasilitas yang ada di ruang perawatan dan prosedur penggunaannya.
 - d. Menjelaskan tata tertib di rumah sakit.
 - e. Menjelaskan hak dan kewajiban pasien.
 - f. Memberikan penjelasan dokter/petugas yang merawat.
 - g. Memberikan informasi waktu konsultasi.
 - h. Menulis di rekam medis informasi catatan perkembangan kondisi pasien dan rencana asuhan keperawatan.
 - i. Memberikan informasi tentang persiapan pulang.
 - j. Setiap selesai melaksanakan orientasi harus tercatat pada checklist dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - k. Sebelum serah terima pasien, perawat harus melakukan :
 - 1) Perawat mendapatkan pengkajian kondisi pasien terkini.
 - 2) Perawat mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan kondisi pasien yang akan dilaporkan.
 - 3) Perawat memastikan diagnosis medis pasien dan prioritas masalah keperawatan yang harus dilanjutkan.
 - 4) Perawat membaca dan memahami catatan perkembangan terkini & hasil pengkajian perawat shift sebelumnya.
 - 5) Perawat menyiapkan medical record pasien termasuk rencana asuhan keperawatan harian.

2.2.3 Daftar untuk Meningkatkan Komunikasi Efektif, Kompetensi Budaya, dan Asuhan Berfokus Pasien dan Keluarga Selama Penerimaan

1. Menginformasikan Pasien Hak-hak Mereka.

Beberapa hak pasien mengatasi kebutuhan yang khusus dari individu, seperti hak untuk memiliki penerjemah bahasa, hak untuk menerima akomodasi untuk penyandang cacat, hak untuk bebas dari diskriminasi ketika menerima pengobatan, hak untuk mengidentifikasi pendamping untuk hadir selama tinggal di rumah sakit, dan untuk menunjuk seorang pembuat keputusan pengganti. Ada beberapa cara untuk memastikan

bahwa pasien diberitahu tentang hak-hak mereka dengan cara mendukung mereka dalam pengobatan mereka :

- a. Kebijakan rumah sakit terkait (dalam bahasa yang sering ditemui) di ruang tunggu
- b. Sertakan informasi tentang kebijakan rumah sakit yang relevan dalam dokumen hak pasien.
- c. Memberikan bahan hak pasien dalam beberapa bahasa dan format alternatif (misalnya audio, materi visual atau tertulis).
- d. Jelaskan hak untuk memiliki penerjemah bahasa, peran penerjemah dalam/pertemuan pengobatan kesehatan, dan itu adalah layanan gratis yang disediakan untuk keselamatan pasien.
- e. Jelaskan hak untuk akomodasi bagi individu penyandang cacat dan layanan yang diberikan untuk membantu pasien dengan kebutuhan komunikasi atau masalah mobilitas.
- f. Menjelaskan hak untuk bebas dari diskriminasi, apakah atau tidak perlindungan anti diskriminasi termasuk dalam undang-undang dan peraturan negara tertentu, karena kebijakan rumah sakit memastikan penyediaan pengobatan yang adil untuk semua pasien.
- g. Jelaskan hak untuk mengidentifikasi dukungan, tujuan dukungan pasien (untuk menghilangkan stres dan memberikan dukungan emosional) dan keterbatasan jika ada pelanggaran dukungan hak-hak lainnya, kompromi keamanan, atau secara medis atau terapi kontraindikasi.
- h. Jelaskan hak untuk menunjuk pembuat keputusan pengganti dan bahwa pembuat keputusan pengganti mungkin anggota keluarga, didefinisikan secara luas untuk memasukkan teman-teman dan mitra yang sama.

2. Mengidentifikasi Bahasa yang Disukai Pasien untuk Mendiskusikan Pengobatan Kesehatan.

Untuk pasien yang belum dewasa atau tidak mampu, bahasa yang diinginkan dari orang tua pasien, wali atau pembuat keputusan pengganti juga harus ditentukan.

- a. Tanya pasien, "Dalam bahasa apa yang anda pilih untuk mendiskusikan pengobatan kesehatan anda?". Rumah sakit harus menentukan bahasa yang dipilih pasien, terlepas apakah pasien berbicara bahasa Inggris dengan lancar atau menggunakan bahasa lain untuk berkomunikasi.
- b. Mengidentifikasi bahasa isyarat yang dipilih pasien yang menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi (bahasa isyarat Amerika, bahasa isyarat Inggris, atau untuk pasien yang tuli atau sulit mendengar dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang terbatas, bahasa isyarat dari negara lain).
- c. Perhatikan bahasa pilihan pasien untuk diskusi pengobatan kesehatan dalam catatan medis dan mengkomunikasikan informasi ini kepada staf.

3. Identifikasi Apakah Pasien Memiliki Kebutuhan Sensorik atau Komunikasi tertentu.

Pasien dengan pra pendengaran, visual atau gangguan bicara mungkin tiba di rumah sakit dengan alat bantu komunikasi mereka sendiri atau perangkat. Untuk pasien yang mengalami gangguan sensorik atau komunikasi karena kondisi kesehatan mereka saat ini, mungkin perlu untuk rumah sakit memberikan bantuan dan layanan tambahan atau tambahan dan sumber alternatif komunikasi (AAC) untuk memfasilitasi komunikasi.

- a. Tanya pasien, "Apakah anda memiliki alat bantu dengar, kacamata, atau perangkat lain yang rutin anda gunakan untuk berkomunikasi?". Jika pasien memiliki bantuan pribadi atau perangkat, staf harus memastikan bahwa pasien dapat mengaksesnya setiap saat selama tinggal di rumah sakit.
- b. Perhatikan kebutuhan sensorik atau komunikasi dan menyebutkan bantuan pribadi atau perangkat, bantuan tambahan atau sumber daya AAC dalam medis dan mengkomunikasikan kebutuhan ini pada staf.

4. Mengumpulkan Data Ras dan Etnis Pasien dalam Laporan Medis.

Rumah sakit harus mengumpulkan data tingkat demografi ras dan etnis pasien untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien individu dan untuk menghilangkan kesenjangan dalam populasi pasien. Data penting ini memberikan informasi pada rumah sakit tentang kebutuhan potensi budaya masing-masing pasien, serta kesempatan untuk memantau dan menganalisis disparitas kesehatan pada tingkat populasi.

- a. Memastikan bahwa pasien mengerti mengapa data ras dan etnis dikumpulkan. Penelitian Kesehatan dan Pendidikan merekomendasikan bahwa staf menjelaskan pada pasien “Kami ingin memastikan bahwa semua pasien kami mendapatkan pengobatan terbaik terlepas dari latar belakang ras dan etnis mereka. Kami ingin anda memberitahu latar belakang ras dan etnis anda sehingga kita dapat meninjau pengobatan dimana pasien menerima dan memastikan bahwa semua orang mendapat pengobatan kualitas tinggi.
- b. Mengizinkan pasien untuk melaporkan sendiri informasi ras dan etnis.
- c. Menghormati pilihan pasien untuk menolak memberikan informasi ras dan etnis.
- d. Lihat kebijakan dan prosedur rumah sakit untuk mengumpulkan data demografis pasien.

5. Mengidentifikasi Jika Pasien Menggunakan Perangkat Bantu.

Pasien mungkin tiba di rumah sakit dengan salah satu perangkat yang ia gunakan untuk membantu aktivitas hidup dan/atau mobilitas sehari-hari. Ini penting bagi rumah sakit untuk membuat akomodasi dan memastikan bahwa pasien memiliki akses ke perangkat ini selama pengobatan.

- a. Pastikan bahwa setiap alat bantu seperti (layanan hewan, tongkat, alat berjalan, kursi roda, atau perangkat mobilitas lainnya) tersedia untuk pasien di seluruh/kontinum pengobatan.
- b. Mengidentifikasi apakah peralatan khusus harus digunakan selama pengobatan pasien dengan kebutuhan mobilitas.

6. Tanya Pasien jika Ada Kebutuhan Tambahan yang Dapat Mempengaruhinya Dalam Pengobatan.

Meskipun banyak hal yang diidentifikasi mengenai kebutuhan pasien, mungkin ada masalah tambahan (seperti budaya, agama atau spiritual, mobilitas atau kebutuhan lainnya) yang akan membutuhkan staff untuk mengkoordinasikan layanan menggabungkan peralatan khusus, atau merekam informasi tambahan medis pasien.

- a. Mengajukan pertanyaan umum: Apakah ada hal lain yang rumah sakit harus ketahui untuk meningkatkan pengobatan anda?”
- b. Mengidentifikasi apakah pasien memiliki budaya atau agama berdasarkan pada isu-isu kesopanan mengenai pengobatan yang yang diberikan oleh staf dari lawan jenis.
- c. Menentukan apakah ada pakaian tertentu atau item agama penting yang perlu dipakai.
- d. Mencatat setiap kebutuhan tambahan dalam rekam medis dan berkomunikasi kebutuhan ini dengan staf.

7. Mengkomunikasikan Informasi pada Tim Pengobatan tentang Kebutuhan untuk Pasien Khusus.

Informasi tentang kebutuhan pasien yang dikumpulkan selama penerimaan dapat membantu staf mengkoordinasikan bantuan komunikasi, rencana untuk akomodasi budaya atau agama atau spiritual, menyediakan peralatan yang diperlukan di seluruh kontinum pengobatan.

- a. Catat semua data yang relevan dalam catatan medis pasien.

- b. Membuat proses untuk identifikasi pasien dengan kebutuhan khusus (misalnya kode warna grafik pasien, menambahkan bendera atau stiker untuk grafik pasien, atau menggunakan gelang pasien untuk menunjukkan kebutuhan pasien yang berbeda).
- c. Pastikan bahwa data yang dikumpulkan selama pendaftaran dapat ditransfer ke database klinis untuk penggunaan di titik pengobatan, terutama jika beberapa sistem data yang digunakan adalah untuk menangkap informasi pasien.

2.2.4 Daftar untuk Meningkatkan Komunikasi Efektif, Kompetensi Budaya, dan Pengobatan Terpusat Pasien dan Keluarga Selama Asesmen

1. Mengidentifikasi dan Mengatasi Kebutuhan Komunikasi Pasien selama Asesmen

Kebutuhan komunikasi pasien dan dukungan harus dicatat dalam rekam medis pasien, dan setiap kebutuhan komunikasi yang didokumentasikan harus memicu untuk mengatur bantuan komunikasi yang tepat.

- a. Periksa rekam medis pasien untuk menentukan apakah ada kebutuhan komunikasi yang sebelumnya diidentifikasi, termasuk bahasa pilihan pasien dan setiap kebutuhan sensorik atau komunikasi.
- b. Mengatur layanan bahasa selama asesmen untuk membantu pasien yang bahasa pilihannya bukan bahasa Inggris atau yang tuli.
- c. Memastikan bahwa alat bantu dan layanan tambahan tersedia selama asesmen untuk pasien yang mengalami gangguan sensorik.
- d. Menyediakan sumber augmentatif dan komunikasi alternatif untuk pasien dengan gangguan komunikasi untuk membantu selama asesmen.
- e. Tentukan apakah pasien telah mengembangkan gangguan komunikasi sejak penerimaan sebagai perubahan status kesehatan yang mungkin dapat mengganggu kemampuan pasien untuk berkomunikasi. Menyediakan sumber AAC untuk membantu selama asesmen dan menghubungi Departemen Patologi Bahasa, jika tersedia.
- f. Perhatikan penggunaan bantuan komunikasi dalam catatan medis dan mengkomunikasikan kebutuhan ini pada staf.

2. Mengawasi Penyedia Hubungan Pasien dengan Pengenalan.

Penyedia individu dapat menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan dan preferensi pasien dengan menjelaskan perannya pada tim pengobatan dan meminta pasien bagaimana ia lebih suka ditangani.

- a. Memastikan bahwa semua anggota tim pengobatan memperkenalkan diri kepada pasien dan menjelaskan peran mereka dalam proses pengobatan.
- b. Tanya pasien, “Apakah anda lebih suka ditangani sebagai Tuan, Nona, Nyonya, Dr, atau Yang Terhormat, dengan nama pertama anda, atau dengan nama atau gelar yang disukai?”
- c. Perhatikan nama yang disukai pasien dalam catatan pasien untuk memastikan bahwa staf menangani pasien dengan tepat. Staf harus menyadari bahwa pasien yang diidentifikasi sebagai transgender mungkin memiliki preferensi nama yang berbeda dari nama resmi mereka dan mungkin atau tidak telah mengubah tubuh mereka secara medis.
- d. Tanya pasien apakah ada pertimbangan budaya untuk mengatasi pasien atau anggota keluarganya. Sebagai contoh, beberapa kebudayaan mempertimbangkan kontak mata dengan seseorang adalah tidak hormat, sementara yang lain menghargai kontak mata langsung.

3. Mendukung Kemampuan Pasien untuk Memahami dan Bertindak Atas Informasi Kesehatan.

Pasien dengan keaksaraan kesehatan yang rendah mungkin memiliki kesulitan besar memahami informasi kesehatan mereka, partisipasi dalam keputusan pengobatan, dan menindaklanjuti dengan rencana-rencana pengobatan.

- a. Mengajukan pertanyaan keaksaraan kesehatan pasien, seperti, “Apakah anda memerlukan bantuan untuk memahami informasi kesehatan?”.
- b. Tanyakan pada pasien bagaimana ia lebih memilih untuk menerima informasi (misalnya, dengan membaca, mendengar, atau melihatnya).
- c. Berbicara dalam bahasa sederhana daripada menggunakan istilah teknis atau jargon medis. Sertakan contoh dan cerita bila memungkinkan.
- d. Gunakan model visual, diagram, atau gambar untuk menggambarkan prosedur atau kondisi.
- e. Membantu pasien mengumpulkan informasi dasar kesehatan dengan menggunakan metode seperti AskMe, strategi untuk bertanya dan menjawab tiga pertanyaan tentang pengobatan pasien.
- f. Menggunakan metode “teach back” untuk menilai pemahaman dengan meminta pasien untuk menjelaskan pada staf dalam kata-katanya sendiri atau dengan meminta pasien untuk menunjukkan keterampilan yang diajarkan.
- g. Menahan diri bertanya pada pasien. “Anda mengerti?”. Terlepas dari kemampuan mereka untuk memahami informasi, banyak orang yang tidak mengerti mungkin masih menjawab “Ya”.
- h. Mendorong pasien untuk menulis catatan pada materi pasien selama diskusi.

4. Identifikasi dan Memenuhi Kebutuhan Mobilitas Pasien selama Asesmen.

Banyak pasien dengan kebutuhan mobilitas mengalami kesulitan secara fisik mengakses peralatan medis. Ketika peralatan khusus tidak tersedia, staf dapat melakukan pemeriksaan dan tes dengan cara yang dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat atau menyembunyikan bukti fisik yang diperlukan untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat, misalnya melakukan sinar x saat pasien duduk di kursi roda. Selain itu, pasien dengan mobilitas yang belum terpenuhi karena stroke yang baru terjadi, perubahan status kesehatan, atau efek samping pengobatan yang mungkin mempengaruhi risiko untuk jatuh.

- a. Menilai apakah pasien memerlukan bantuan mobilitas, termasuk jenis dan keadaan dimana bantuan diperlukan.
- b. Pastikan pasien telah ditetapkan ke sebuah ruangan yang dapat mengakomodasi kebutuhan mobilitasnya.
- c. Pastikan bantuan mobilitas yang pasien gunakan (seperti layanan hewan, tongkat, atau alat berjalan) mudah diakses pasien.
- d. Menentukan apakah pasien membutuhkan akomodasi (seperti tombol adaptif atau sistem panggilan interkom) untuk mengakses sistem panggilan perawat.
- e. Perhatikan kebutuhan untuk bantuan mobilitas dalam rekam medis dan mengkomunikasikan kebutuhan ini pada staf.
- f. Pastikan tindakan pencegahan yang tepat di tempat untuk mencegah jatuh. Beberapa rumah sakit menempatkan tanda di atas tempat tidur pasien atau pintu, atau gunakan kaos kaki berwarna khusus atau gelang untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko jatuh.

5. Mengidentifikasi Budaya, Agama, atau Kegiatan dan Keyakinan Spiritual yang Mempengaruhi Pengobatan.

Budaya, agama atau keyakinan spiritual dapat mempengaruhi persepsi pasien dan keluarga tentang penyakit dan bagaimana mereka melakukan pengobatan. Selain itu, pasien mungkin memiliki kebutuhan khusus yang terkait dengan budaya, agama, atau keyakinan spiritual mereka dimana staf harus mengakui dan mengatasi.

- a. Tanya pasien apakah ada budaya, agama, atau keyakinan spiritual atau kegiatan yang dapat mempengaruhi pengobatannya.

-
- b. Tanya pasien jika lingkungan rumah sakit menyambut budaya, agama, atau keyakinan spiritual mereka. Beberapa rumah sakit berbasis agama menampilkan item dalam kamar pasien yang mencerminkan organisasi tradisi keagamaan dan mungkin bertentangan dengan budaya, agama atau spiritual pasien dan keluarga. Mempertimbangkan memindahkan item-item tersebut, jika mungkin, atau menutupinya bila diperlukan.
 - c. Menghormati kebutuhan dan preferensi pasien untuk kesopanan dengan menetapkan penyedia yang tepat, membuka hanya bagian tubuh yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengobatan, memberikan privasi di toilet dan pembersihan, dan menggunakan baju penuh atau jubah untuk berjalan dan transportasi. Banyak budaya dan agama memiliki pembatasan menyentuh, jarak, kesopanan, yang mungkin akan terpengaruh oleh penyedia lawan jenis atau staf yang lebih muda atau lebih tua dari pasien.
 - d. Menentukan apakah pasien menggunakan obat atau praktik komplementer atau alternatif obat. Jika sesuai, pertimbangkan memasukan ini ke dalam pengobatan pasien.
 - e. Berkonsultasi dengan tokoh agama, jika tersedia untuk menyelesaikan penilaian spiritual. Tokoh agama mungkin memiliki pertanyaan skrining untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan keagamaan, teknik relaksasi, dan sumber daya lain yang mungkin mempengaruhi pengobatan.
 - f. Menyediakan ruang atau area untuk mengakomodasi kebutuhan pasien untuk berdoa. Selain itu, meminta pasien jika ada waktu tertentu dalam sehari untuk menghindari penjadwalan tes atau prosedur untuk menghormati agama atau kegiatan spiritual pasien.
 - g. Mencatat setiap kebutuhan budaya, agama atau kebutuhan spiritual yang mempengaruhi pengobatan dalam catatan medis dan mengkomunikasikan preferensi ini pada staf.
6. Mengidentifikasi Kebutuhan Makanan Pasien atau Pembatasan yang Mempengaruhi Pengobatan.
- Kebutuhan makanan dan pembatasan dapat timbul dari budaya, agama, atau praktik spiritual, atau mereka mungkin berhubungan dengan kondisi medis pasien. Beberapa pengobatan menggunakan produk sampingan hewan sebagai pengikat dan pengisi, dan staf harus menyadari pembatasan makanan pasien, jika mungkin memilih pengobatan alternatif.
- a. Tanya pasien "Apakah ada sesuatu yang penyedia anda harus ketahui mengenai makanan anda?"
 - b. Identifikasi apakah agama atau keyakinan spiritual pasien atau kebiasaan agama pasien melarang makanan-makanan tertentu.
 - c. Memastikan apakah pasien secara rutin atau berkala mengamati kegiatan puasa (misalnya, pada hari libur keagamaan).
 - d. Perhatikan kebutuhan makanan dan pembatasan dalam catatan medis dan komunikasikan pada staf.
 - e. Pastikan pelayanan makanan rumah sakit mengakomodasi kebutuhan pasien.
7. Meminta Pasien Mengidentifikasi Pendamping.
- Pendamping pasien harus memberikan dukungan emosional, memberikan kenyamanan, dan mengurangi rasa takut selama pasien tinggal di rumah sakit. Pasien harus memiliki akses ke pendukung pilihan mereka setiap saat.
- a. Jelaskan tujuan pendamping untuk pasien, termasuk batasan-batasan jika kehadiran individu tersebut melanggar hak-hak orang lain, kompromi keselamatan, atau secara medis, atau terapi kontraindikasi.
 - b. Membuat staf menyadari bahwa pasien telah memilih pendamping untuk hadir selama dia tinggal.

- c. Mengizinkan pasien untuk bisa akses ke pendamping setiap saat.
 - d. Tanya pasien apakah ingin melibatkan pendamping yang dipilihnya selama berkeliling, pendidikan pasien, dan pengambilan keputusan penting, dan proses pengobatan lainnya. Pendamping mungkin atau tidak ditunjuk sebagai pengganti pasien dalam mengambil keputusan.
 - e. Perhatikan informasi tentang pendamping pasien dalam catatan medis dan komunikasikan pada staf seleksi.
8. Mengkomunikasikan Informasi tentang Kebutuhan Pasien Khusus pada Tim Asuhan.
- Setiap informasi tentang kebutuhan pasien harus mudah diakses di semua titik pengobatan dan di departemen-departemen lain yang sesuai untuk membantu staf memberikan layanan dan pengaturan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasien.
- a. Catat semua data yang relevan dalam catatan medis pasien.
 - b. Buat proses untuk mengidentifikasi pasien dengan kebutuhan khusus (misalnya, kode warna grafik pasien, menambahkan bendera atau stiker pada grafik, atau gunakan gelang pasien untuk menunjukkan kebutuhan pasien yang berbeda). Mempertimbangkan menempatkan tanda-tanda pada pintu atau di atas tempat tidur pasien, atau menggunakan papan tulis di ruang pasien untuk komunikasi, dengan izin pasien, informasikan pada staf.
 - c. Informasikan staf akan kebutuhan pasien pada titik transfer tertentu, termasuk transfer untuk prosedur, tes, atau transfer ke unit atau pelayanan yang berbeda.

2.2.5 Daftar untuk Meningkatkan Komunikasi Efektif, Kompetensi Budaya, dan Pengobatan Terpusat Pasien dan Keluarga Selama Pengobatan.

1. Mengatasi Kebutuhan Komunikasi Pasien Selama Pengobatan.
- Bantuan komunikasi diperlukan selama pengobatan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi sebelumnya diidentifikasi selama penerimaan dan asesmen. Mencatat informasi ini dalam data medis pasien sehingga setiap kebutuhan komunikasi didokumentasikan, memicu staf untuk mengatur bantuan komunikasi yang tepat.
- a. Memeriksa rekam medis pasien untuk setiap kebutuhan komunikasi diidentifikasi, termasuk bahasa pilihan pasien dan setiap gangguan sensorik atau komunikasi.
 - b. Atur layanan bahasa untuk membantu pengobatan pasien yang memilih tidak berbahasa Inggris atau yang tuli.
 - c. Pastikan bahwa bantuan dan layanan tambahan tersedia selama pengobatan pasien yang memiliki gangguan sensorik.
 - d. Memberikan sumber augmentatif dan komunikasi alternatif (AAC) untuk membantu pengobatan pasien dengan gangguan komunikasi.
 - e. Perhatikan penggunaan bantuan komunikasi dalam catatan medis dan komunikasikan bantuan dan layanan yang diperlukan pada staf.
2. Memantau Perubahan Status Komunikasi Pasien.
- Sebuah perubahan status kesehatan atau hasil dari pengobatan atau prosedur medis dapat mengganggu kemampuan pasien untuk berkomunikasi. Pasien dapat mengembangkan gangguan komunikasi baru atau lebih parah selama pengobatan, dan staf harus secara berkala menilai perubahan status komunikasi pasien.
- a. Menentukan apakah pasien telah mengembangkan gangguan komunikasi baru atau lebih parah selama pengobatan dan menghubungi Departemen Patologi Bahasa, jika tersedia. Menyediakan sumber daya AAC, sesuai kebutuhan, untuk membantu selama pengobatan.
 - b. Mengantisipasi kebutuhan komunikasi pasien yang diharapkan dapat mengembangkan gangguan komunikasi pengobatan terjadwal atau prosedur (misalnya, seperti akibat dari intubasi, tracheostomy, sedation, atau intervensi lainnya

yang dapat mengganggu kemampuan pasien untuk berkomunikasi). Selain itu, mempertimbangkan apakah posisi tempat tidur atau peralatan medis untuk pengobatan atau prosedur akan menghambat pasien menggunakan sumber daya AAC yang dibutuhkan.

- c. Mencatat setiap perubahan status komunikasi pasien pada catatan medis dan mengkomunikasikan kebutuhan baru pada staf.

2.2.6 Melibatkan Pasien dan Keluarga Dalam Proses Pengobatan.

Staff harus melibatkan pasien dan keluarganya untuk mengembangkan rencana pengobatan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus pasien. Staf harus mendorong pasien dan keluarga untuk mengajukan pertanyaan sepanjang perjalanan pengobatan dan memberikan kesempatan pada mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi pengobatan.

1. Menanyakan pasien, jika ada, anggota keluarganya yang ingin terlibat dalam diskusi pengobatan. Anggota keluarga dapat mendefinisikan secara luas untuk memasukkan teman-teman dan pasangan dengan jenis kelamin yang sama, termasuk jenis kelamin orang tua yang sama.
2. Mengadaptasi prosedur rumah sakit yang ada untuk lebih melibatkan pasien dan keluarga dalam diskusi pengobatan. Sebagai contoh, perhatikan penjadwalan ulang pasien atau memastikan informasi yang diberikan pada pasien tersedia untuk anggota keluarga pasien di kemudian hari.
3. Mendesak pasien untuk mengambil peran dalam mencegah kesalahan pengobatan kesehatan dengan menjadi aktif, terlibat, dan memberitahu peserta di tim pengobatan. *The Joint Commission*, bersama dengan *the Centers for Medicare dan Medicaid Services*, memiliki program nasional *Speak Up* yang menampilkan brosur, poster, dan berbagai topik keselamatan pasien.
4. Mempertimbangkan memberi bantuan komunikasi untuk anggota keluarga yang memilih bahasa yang disukai bukan bahasa Inggris atau yang memiliki gangguan sensorik atau komunikasi, memfasilitasi keterlibatan keluarga dalam diskusi pengobatan.
5. Memastikan bahwa dukungan komunikasi yang tepat berada ditempat selama diskusi pengobatan; keluarga dan teman tidak boleh digunakan untuk menafsirkan.
6. Beritahu pasien dan keluarga peluang berkelanjutan untuk mengajukan pertanyaan. Mendorong pasien dan keluarga untuk menuliskan pertanyaan untuk diskusi dengan pengasuh.

2.2.7 Sesuaikan Proses Arahan Informasi untuk Memenuhi Kebutuhan Pasien.

Proses persetujuan diinformasikan memungkinkan pasien dan penyedia untuk membangun saling pengertian tentang pengobatan, pengobatan, dan pelayanan yang akan pasien terima. Memenuhi kebutuhan khusus dan preferensi pasien selama diskusi menggabungkannya ke dalam bahan tertulis dan formulir yang relevan. Ini mendukung kemampuan pasien untuk memahami dan bertindak atas informasi kesehatan.

1. Tanyakan pada pasien bagaimana ia lebih memilih untuk menerima informasi (misalnya, dengan membaca, mendengar, atau melihat).
2. Berbicara dalam bahasa sederhana dan hindari menggunakan istilah teknis atau jargon medis. Sertakan contoh dan cerita bila memungkinkan.
3. Gunakan model visual, diagram, atau gambar menjelaskan prosedur atau kondisi.
4. Membantu pasien mengumpulkan informasi kesehatan dasar dengan menggunakan metode seperti *AskMe*, strategi untuk bertanya dan menjawab tiga pertanyaan tentang pengobatan pasien.
5. Gunakan metode “teach back” untuk menilai pemahaman. Keterlibatan ini meminta pasien untuk menjelaskan dalam kata-katanya sendiri informasi yang staf bagi atau meminta pasien menunjukkan keterampilan yang diajarkan.
6. Menahan diri dari menanyakan pada pasien, “Apakah anda mengerti?”. Terlepas dari kemampuan mereka untuk memahami informasi, banyak orang yang tidak mengerti mungkin masih menjawab “Ya”.

7. Beritahu pasien peluang berkelanjutan untuk mengajukan pertanyaan. Mendorong pasien untuk menulis catatan atau periksa informasi penting pada bahan pasien selama diskusi.
8. Gunakan bahan arahan informasi yang memenuhi kebutuhan keaksaraan kesehatan. Bahan harus ditulis pada level 5 atau tingkat membaca yang lebih rendah. Mempertimbangkan revisi materi tertulis untuk mengatasi kebutuhan keaksaraan kesehatan dari semua pasien. Gunakan tes baca, membagi informasi kompleks menjadi poin-poin, dan modifikasi huruf dokumen, tata letak, dan memperbaiki desain untuk lebih mudah dibaca.
9. Bila memungkinkan gunakan bahan terjemahan arahan informasi dalam bahasa pasien. Menyediakan penerjemah untuk bahasa yang dipilih pasien selama diskusi, bahkan jika rumah sakit menyediakan bahan terjemahan, untuk memudahkan komunikasi pasien.
10. Jika dokumen terjemahan tidak tersedia, penerjemah sebaiknya tidak berupaya menerjemahkan secara pandangan; sebaliknya dokter harus memiliki persetujuan secara lisan.
11. Perhatikan penerimaan persetujuan informasi dan bantuan komunikasi yang digunakan untuk mendapatkannya dalam rekam medis.

2.2.8 Memberikan Pendidikan Pasien yang Memenuhi Kebutuhan Pasien.

Diskusi pendidikan pasien dan bahan harus diubah untuk kemampuan pasien memahami dan bertindak atas informasi kesehatan.

1. Tanyakan pada pasien bagaimana ia lebih memilih untuk menerima informasi (misalnya, dengan membaca, mendengar, atau melihat).
2. Berbicara dalam bahasa sederhana dan hindari menggunakan istilah teknis atau jargon medis. Sertakan contoh dan cerita bila memungkinkan.
3. Gunakan model visual, diagram, atau gambar menjelaskan prosedur atau kondisi.
4. Membantu pasien mengumpulkan informasi kesehatan dasar dengan menggunakan metode seperti AskMe, strategi untuk bertanya dan menjawab tiga pertanyaan tentang pengobatan pasien.
5. Gunakan metode “teach back” untuk menilai pemahaman. Keterlibatan ini meminta pasien untuk menjelaskan dalam kata-katanya sendiri informasi yang staf bagi atau meminta pasien menunjukkan keterampilan yang diajarkan.
6. Menahan diri dari menanyakan pada pasien, “Apakah anda mengerti?”. Terlepas dari kemampuan mereka untuk memahami informasi, banyak orang yang tidak mengerti mungkin masih menjawab “Ya”.
7. Mendorong pasien untuk menulis catatan atau memeriksa informasi penting pada bahan pasien selama diskusi.
8. Gunakan bahan arahan informasi yang memenuhi kebutuhan keaksaraan kesehatan. Bahan harus ditulis pada level 5 atau tingkat membaca yang lebih rendah. Mempertimbangkan revisi materi tertulis untuk mengatasi kebutuhan keaksaraan kesehatan dari semua pasien. Gunakan tes baca, membagi informasi kompleks menjadi poin-poin, dan modifikasi huruf dokumen, tata letak, dan memperbaiki desain untuk lebih mudah dibaca.
9. Bila memungkinkan gunakan bahan terjemahan arahan informasi dalam bahasa pasien. Menyediakan penerjemah untuk bahasa yang dipilih pasien selama diskusi, bahkan jika rumah sakit menyediakan bahan terjemahan, untuk memudahkan komunikasi pasien.

2.2.9 Mengatasi Kebutuhan Mobilitas Pasien Selama Pengobatan.

Banyak pasien dengan kebutuhan mobilitas mengalami kesulitan secara fisik mengakses peralatan medis. Ketika peralatan khusus tidak tersedia, staf dapat melakukan pemeriksaan dan tes dengan cara yang dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat atau menyembunyikan bukti fisik yang diperlukan untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat, misalnya melakukan sinar x saat pasien duduk di kursi roda. Selain itu, pasien dengan mobilitas yang belum terpenuhi karena stroke yang baru terjadi, perubahan status kesehatan, atau efek samping pengobatan yang mungkin mempengaruhi risiko untuk jatuh.

1. Menilai apakah pasien memerlukan bantuan mobilitas, termasuk jenis dan keadaan dimana bantuan diperlukan.
2. Pastikan pasien telah ditetapkan ke sebuah ruangan yang dapat mengakomodasi kebutuhan mobilitasnya.
3. Pastikan bantuan mobilitas yang pasien gunakan (seperti layanan hewan, tongkat, atau alat berjalan) mudah diakses pasien.
4. Menentukan apakah pasien membutuhkan akomodasi (seperti tombol adaptif atau sistem panggilan interkom) untuk mengakses sistem panggilan perawat.
5. Pastikan tindakan pencegahan yang tepat di tempat untuk mencegah jatuh. Beberapa rumah sakit menempatkan tanda di atas tempat tidur pasien atau pintu, atau gunakan kaos kaki berwarna khusus atau gelang untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko jatuh.
6. Perhatikan kebutuhan untuk bantuan mobilitas dalam rekam medis dan mengkomunikasikan kebutuhan ini pada staf.

2.2.10 Mengakomodasi Budaya, Agama, dan Kegiatan atau Keyakinan Spiritual Pasien.

Keyakinan dan kegiatan pasien dapat mempengaruhi persepsi penyakit dan bagaimana pendekatannya pada pengobatan. Bila memungkinkan, staf harus mengakomodasi kebutuhan pasien khusus.

1. Mengkomunikasikan setiap budaya, agama, atau keyakinan spiritual atau kegiatan yang diidentifikasi staf selama penerimaan atau asesmen pada tim asuh.
2. Menghormati kebutuhan dan preferensi pasien untuk kesopanan dengan menetapkan penyedia yang tepat, membuka hanya bagian tubuh yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengobatan, memberikan privasi di toilet dan pembersihan, dan menggunakan baju penuh atau jubah untuk berjalan dan transportasi. Banyak budaya dan agama memiliki pembatasan menyentuh, jarak, kesopanan, yang mungkin akan terpengaruh oleh penyedia lawan jenis atau staf yang lebih muda atau lebih tua dari pasien.
3. Menyediakan ruang atau area untuk mengakomodasi kebutuhan pasien untuk berdoa. Selain itu, meminta pasien jika ada waktu tertentu dalam sehari untuk menghindari penjadwalan tes atau prosedur untuk menghormati agama atau kegiatan spiritual pasien.
4. Bekerjasama dengan pasien dan keluarga untuk mengembangkan solusi untuk pasien sesuai yang disetujui kedua belah pihak mengenai permintaan kegiatan, budaya, agama, atau keyakinan spiritual pasien. Misalnya, di beberapa budaya, keluarga pasien mungkin ingin menyalakan lilin di bawah tempat tidur pasien. Penggunaan lilin di rumah sakit mungkin tidak diizinkan; bagaimanapun, satu kompromi yang potensial menyarankan keluarga menggunakan senter bukan lilin.
5. Perhatikan setiap kebutuhan budaya, agama, atau spiritual yang mempengaruhi pengobatan pasien di rekam medis dan komunikasikan preferensi pasien pada staf.

2.2.11 Memantau Perubahan Kebutuhan Makanan atau Pembatasan yang dapat Mempengaruhi Pengobatan Pasien.

Kebutuhan makanan dan pembatasan akan diidentifikasi selama proses penerimaan dan asesmen, tetapi kebutuhan-kebutuhan baru dan pembatasan mungkin timbul karena kondisi medis pasien atau selama pengobatan.

1. Menginformasikan pada pasien setiap kebutuhan makanan baru atau pembatasan berdasarkan pada pengobatannya dan obat-obatan.
2. Catat kebutuhan darurat makanan atau pembatasan dalam rekam medis dan komunikasikan perubahan pada staf.
3. Beritahu pelayanan makanan rumah sakit untuk mengakomodasi kebutuhan pasien.

2.2.12 Meminta Pasien untuk Memilih Pendamping jika ada yang belum Diidentifikasi.

Pasien harus memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi individu untuk memberi dukungan emosional, memberi kenyamanan, dan mengurangi rasa takut selama pasien tinggal di rumah sakit. Kebutuhan pasien dapat berubah sepanjang kontinum pengobatan, dan pasien yang tidak memilih pendamping pada saat penerimaan atau asesmen dapat memilih untuk melakukannya setiap saat selama masa pengobatan.

1. Jelaskan tujuan dukungan seseorang untuk pasien, termasuk batasan-batasan jika kehadiran individu tersebut melanggar hak-hak orang lain, kompromi keselamatan, atau secara medis, atau terapi kontraindikasi.
2. Membuat staf menyadari bahwa pasien telah memilih pendamping untuk hadir selama dia tinggal.
3. Mengizinkan pasien untuk bisa akses ke pendamping setiap saat.
4. Tanya pasien apakah ingin melibatkan pendamping yang dipilihnya selama berkeliling, pendidikan pasien, dan pengambilan keputusan penting, dan proses pengobatan lainnya. Pendamping mungkin atau tidak ditunjuk sebagai pengganti pasien dalam mengambil keputusan.
5. Perhatikan informasi tentang pendamping pasien dalam catatan medis dan komunikasikan pada staf seleksi.

2.2.13 Komunikasikan Informasi tentang Kebutuhan Khusus Pasien pada Tim Asuhan.

Informasi tentang kebutuhan pasien harus mudah dan mudah diakses di semua titik pengobatan dan di semua departemen-departemen pendukung yang relevan untuk membantu staf memberikan layanan yang dibutuhkan dan mengaturnya untuk memenuhi kebutuhan pasien.

1. Catat semua data yang relevan di rekam medis pasien.
2. Buat proses untuk mengidentifikasi pasien dengan kebutuhan khusus (misalnya, kode warna grafik pasien, menambahkan bendera atau stiker pada grafik, atau gunakan gelang pasien untuk menunjukkan kebutuhan pasien yang berbeda). Mempertimbangkan menempatkan tanda-tanda pada pintu atau diatas tempat tidur pasien, atau menggunakan papan tulis di ruang pasien untuk komunikasi, dengan izin pasien, informasikan pada staf.
3. Informasikan staf akan kebutuhan pasien pada titik transfer tertentu, termasuk transfer untuk prosedur, tes, atau transfer ke unit atau pelayanan yang berbeda.

2.2.14 Daftar untuk Meningkatkan Komunikasi Efektif, Kompetensi Budaya, dan Pengobatan Terpusat Pasien dan Keluarga Selama Pengobatan Akhir

1. Mengatasi Kebutuhan Komunikasi Pasien Selama Pengobatan Akhir.

Bantuan komunikasi harus disediakan selama pengobatan akhir untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pasien diidentifikasi diseluruh kontinum pengobatan. Informasi ini harus dicatat dalam rekam medis pasien sehingga setiap kebutuhan komunikasi yang didokumentasikan memicu staf untuk mengatur bantuan komunikasi yang tepat.

- a. Periksa rekam medis pasien untuk setiap kebutuhan komunikasi diidentifikasi, termasuk bahasa pilihan pasien dan setiap gangguan sensorik atau komunikasi.
- b. Atur layanan bahasa untuk membantu pengobatan pasien yang memilih tidak berbahasa Inggris atau yang tuli.
- c. Pastikan bahwa bantuan dan layanan tambahan tersedia selama pengobatan pasien yang memiliki gangguan sensorik.
- d. Memberikan sumber augmentatif dan komunikasi alternatif (AAC) untuk membantu pengobatan pasien dengan gangguan komunikasi.
- e. Perhatikan penggunaan bantuan komunikasi dalam catatan medis dan komunikasikan bantuan dan layanan yang diperlukan pada staf.
- f. Memberikan bantuan komunikasi kepada para pembuat keputusan pengganti yang bahasa pilihannya bukan bahasa Inggris atau memiliki gangguan sensorik atau

kebutuhan komunikasi untuk melibatkan pengambil keputusan pengganti pasien dalam diskusi pengobatan.

2. Memantau Perubahan Status Komunikasi Pasien Selama Pengobatan Akhir.

Sebuah perubahan status kesehatan atau hasil dari pengobatan atau prosedur medis dapat mengganggu kemampuan pasien untuk berkomunikasi. Pasien dapat mengembangkan gangguan komunikasi baru atau lebih parah pada akhir hidupnya, dan staf harus mengetahui setiap adanya perubahan pada status komunikasi pasien.

- a. Menentukan apakah pasien telah mengembangkan gangguan komunikasi baru atau lebih parah selama akhir pengobatan dan menghubungi Departemen Patologi Bahasa, jika tersedia. Menyediakan sumber daya AAC, sesuai kebutuhan, untuk membantu selama pengobatan.
- b. Mengantisipasi kebutuhan komunikasi pasien yang diharapkan dapat mengembangkan gangguan komunikasi pengobatan terjadwal atau prosedur (misalnya, seperti akibat dari intubasi, tracheostomy, sedation, atau intervensi lainnya yang dapat mengganggu kemampuan pasien untuk berkomunikasi).
- c. Mencatat setiap perubahan status komunikasi pasien pada catatan medis dan mengkomunikasikan kebutuhan baru pada staf.

3. Libatkan Pengambil Keputusan Pengganti Pasien dan Keluarga di Pengobatan Akhir.

Pembuat keputusan pengganti dan keluarga pasien harus terlibat (per keinginan pasien) untuk menyesuaikan pengobatan akhir untuk kebutuhan pasien khusus. Staf harus memastikan bahwa pengambil keputusan pengganti dan keluarga memiliki kesempatan mengajukan pertanyaan dan memberikan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi pengobatan.

- a. Ingatkan pasien akan haknya untuk menunjuk pembuat keputusan pengganti. Jika pasien tidak memiliki pembuat keputusan pengganti, dorong pasien untuk mengidentifikasi individu selama pengobatan akhir.
- b. Tanyakan pada pasien yang, jika ada, anggota keluarganya yang ingin terlibat dalam pengobatan akhir. Anggota keluarga dapat didefinisikan secara luas untuk memasukkan teman-teman dan mitra yang sama jenis kelaminnya.
- c. Banyak kelompok budaya lebih suka bahwa keluarga pasien, berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Situasi ini tampaknya bertentangan penekanan pada otonomi pasien dan persetujuan. Namun staf perlu menghormati keinginan pasien untuk menggunakan pembuat keputusan pengganti bahkan jika pasien sanggup. Dalam hal demikian staf harus mencatat bahwa pasien telah ditangguhkan pengambil keputusan untuk alasan budaya dan mengidentifikasi pengambil keputusan pengganti dalam rekam medis.
- d. Mendidik pasien dan pengambil keputusan pengganti dan keluarga mengenai proses sekarat.
- e. Mengizinkan keluarga untuk berpartisipasi dalam pengobatan akhir dengan memberikan kenyamanan selama proses sekarat dengan menyentuh, berbicara, mendengarkan musik favorit, atau berpartisipasi dalam aktivitas pengobatan seperti pembersihan.
- f. Mengadaptasi prosedur rumah sakit yang ada untuk lebih melibatkan pembuat keputusan pengganti dan keluarga dalam diskusi pengobatan. Sebagai contoh, mempertimbangkan penjadwalan ulang putaran pasien, atau memastikan informasi yang diberikan selama putaran tersedia untuk pengambil keputusan pengganti dan anggota keluarga di lain waktu.
- g. Memberi bantuan komunikasi untuk pengambil keputusan pengganti dan anggota keluarga yang bahasa pilihannya bukan bahasa Inggris atau yang memiliki gangguan sensorik atau komunikasi untuk memfasilitasi keterlibatan di akhir pengobatan.

-
- h. Pastikan bahwa dukungan komunikasi tepat berada di tempat selama membahas pengobatan. Staf tidak harus bergantung pada keluarga atau teman pasien untuk menafsirkan.
 - i. Beritahu pasien dan keluarga peluang berkelanjutan untuk mengajukan pertanyaan. Mendorong pasien dan keluarga untuk menuliskan pertanyaan untuk diskusi dengan pengasuh.
 4. Memenuhi Kebutuhan Mobilitas Pasien Selama Pengobatan Akhir.

Pasien menerima pengobatan akhir mungkin dapat mengembangkan kebutuhan mobilitas baru atau tambahan. Pasien juga mungkin pada peningkatan risiko jatuh.

 - a. Menilai apakah pasien memerlukan bantuan mobilitas, termasuk jenis dan keadaan dimana bantuan diperlukan.
 - b. Menentukan apakah pasien membutuhkan akomodasi (seperti tombol adaptif atau sistem panggilan interkom) untuk mengakses sistem panggilan perawat.
 - c. Pastikan tindakan pencegahan yang tepat di tempat untuk mencegah jatuh. Beberapa rumah sakit menempatkan tanda di atas tempat tidur pasien atau pintu, atau gunakan kaos kaki berwarna khusus atau gelang untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko jatuh.
 - d. Perhatikan kebutuhan untuk bantuan mobilitas dalam rekam medis dan mengkomunikasikan kebutuhan ini pada staf.
 5. Mengidentifikasi Budaya, Agama, atau Keyakinan Spiritual dan Kegiatan Selama Pengobatan Akhir.

Budaya, agama atau keyakinan spiritual dapat mempengaruhi persepsi pasien dan keluarga tentang penyakit dan bagaimana mereka mendekati kematian dan sekarat. Akhir situasi kehidupan sering memicu tekanan dan mengurangi kemampuan pasien untuk mengatasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam keputusan pengobatan.

 - a. Menanyakan pasien apakah ada budaya, agama, atau keyakinan spiritual atau kegiatan yang dapat mempengaruhi pengobatannya.
 - b. Konsultasikan dengan tokoh agama profesional, bila memungkinkan ketika staf mengidentifikasi pasien memasuki pengobatan fase akhir kehidupan. Tokoh agama dapat menyelesaikan asesmen spiritual dan mungkin memiliki pertanyaan untuk mengidentifikasi kegiatan agama, teknik relaksasi, dan mengatasi sumber daya lainnya.
 - c. Memastikan bahwa staf menyadari setiap pakaian, item-item keagamaan, atau ritual penting untuk pasien selama pengobatan akhir.
 - d. Menyediakan ruang atau area untuk mengakomodasi kebutuhan pasien untuk berdoa. Selain itu, meminta pasien dan keluarga jika ada waktu tertentu dalam sehari untuk menghindari penjadwalan tes atau prosedur untuk menghormati agama atau kegiatan spiritual pasien.
 - e. Mencatat setiap kebutuhan budaya, agama atau kebutuhan spiritual pada pengobatan akhir di rekam medis dan komunikasikan preferensi ini pada staf.
 6. Pastikan Pasien Memiliki Akses ke Pendamping yang Dipilihnya.

Pasien harus memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi individu yang memberikan dukungan emosional, kenyamanan, dan mengurangi rasa takut pada akhir kehidupan. Pasien yang tidak memilih pendamping sebelumnya bisa memilih melakukannya selama pengobatan akhir.

 - a. Jelaskan tujuan pendamping untuk pasien, termasuk batasan-batasan jika kehadiran individu tersebut melanggar hak-hak orang lain, kompromi keselamatan, atau secara medis, atau terapi kontraindikasi.

- b. Membuat staf menyadari bahwa pasien telah memilih pendamping untuk hadir selama pengobatan akhir.
- c. Mengizinkan pasien untuk bisa akses ke pendamping setiap saat.
- d. Menanyakan pasien apakah ingin melibatkan pendamping yang dipilihnya selama berkeliling, pendidikan pasien, dan pengambilan keputusan penting, dan proses pengobatan lainnya. Pendamping mungkin atau tidak ditunjuk sebagai pengganti pasien dalam mengambil keputusan.
- e. Perhatikan informasi tentang pendamping pasien dalam catatan medis dan komunikasikan pada staf seleksi.

2.2.15 Daftar untuk Meningkatkan Komunikasi Efektif, Kompetensi Budaya, dan Pengobatan Terpusat Pasien dan Keluarga Selama Pemulangan dan Transfer.

1. Mengatasi Kebutuhan Komunikasi Pasien Selama Pemulangan dan Transfer.

Bantuan komunikasi diperlukan selama pemulangan dan transfer untuk memenuhi kebutuhan komunikasi sebelumnya diidentifikasi selama kursus pengobatan. Mencatat informasi ini dalam data medis pasien sehingga setiap kebutuhan komunikasi didokumentasikan, memicu staf untuk mengatur bantuan komunikasi yang tepat.

- a. Memeriksa rekam medis pasien untuk setiap kebutuhan komunikasi diidentifikasi, termasuk bahasa pilihan pasien dan setiap gangguan sensorik atau komunikasi, yang sebelumnya diidentifikasi.
- b. Atur layanan bahasa untuk memfasilitasi komunikasi selama pemulangan dan rencana transfer dan instruksi untuk pasien yang memilih tidak berbahasa Inggris atau yang tuli.
- c. Pastikan bahwa bantuan dan layanan tambahan tersedia selama pemulangan dan rencana transfer dan instruksi untuk pasien yang memiliki kebutuhan komunikasi sensorik.
- d. Memberikan sumber augmentatif dan komunikasi alternatif (AAC) untuk membantu komunikasi selama pemulangan atau rencana transfer dan instruksi untuk pasien dengan kebutuhan komunikasi.
- e. Perhatikan penggunaan bantuan komunikasi dalam catatan medis dan komunikasikan bantuan dan layanan yang diperlukan pada staf.

2. Melibatkan Pasien dan Keluarga dalam Pemulangan dan Rencana Transfer dan Instruksi.

Staff harus melibatkan pasien dan keluarganya untuk menyesuaikan rencana dan instruksi pemulangan dan transfer untuk kebutuhan khusus pasien. Staf harus mendorong pasien dan keluarga untuk mengajukan pertanyaan sepanjang perjalanan pengobatan dan memberikan kesempatan pada mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang pemulangan dan transisi dalam pengobatan.

- a. Menanyakan pasien, jika ada, anggota keluarganya yang ingin terlibat dalam rencana dan instruksi pemulangan atau transfer. Anggota keluarga dapat mendefinisikan secara luas untuk memasukkan teman-teman dan partner dengan jenis kelamin yang sama. *Bila memungkinkan, staf harus mendiskusikan pengobatan anak dengan kedua orang tuanya, termasuk pengobatan orang tua dan orang tua dengan jenis kelamin sama, bahkan jika keduanya tidak memiliki hak asuh hukum.
- b. Menanyakan pasien jika ia memiliki pengasuh utama di rumah. Staf harus memastikan melibatkan pengasuh utama yang diidentifikasi oleh pasien dalam perencanaan dan instruksi pemulangan.
- c. Mempertimbangkan memberi bantuan komunikasi untuk anggota keluarga yang memilih bahasa pilihannya bukan bahasa Inggris atau yang memiliki gangguan

-
- sensorik atau kebutuhan komunikasi, memfasilitasi keterlibatan keluarga dalam rencana untuk transisi dalam pengobatan.
- d. Memastikan bahwa dukungan komunikasi yang tepat berada ditempat selama diskusi pengobatan; staf tidak harus bergantung pada keluarga atau teman-teman pasien untuk menafsirkan.
 - e. Beritahu pasien dan keluarga peluang berkelanjutan untuk mengajukan pertanyaan. Mendorong pasien dan keluarga untuk menuliskan pertanyaan untuk diskusi dengan staf yang merencanakan transisi dalam pengobatan.
3. Memberikan Instruksi Pemulangan yang Memenuhi Kebutuhan Pasien.
- Rumah sakit harus memodifikasi instruksi dan bahan pemulangan untuk membantu pasien memahami dan bertindak atas informasi kesehatan.
- a. Tanyakan pada pasien bagaimana ia lebih memilih untuk menerima informasi (misalnya, dengan membaca, mendengar, atau melihat).
 - b. Berbicara dalam bahasa sederhana dan hindari menggunakan istilah teknis atau jargon medis. Sertakan contoh dan cerita bila memungkinkan.
 - c. Gunakan model visual, diagram, atau gambar menjelaskan prosedur atau kondisi.
 - d. Membantu pasien mengumpulkan informasi dasar kesehatan.
 - e. Gunakan metode “teach back” untuk menilai pemahaman. Keterlibatan ini meminta pasien untuk menjelaskan dalam kata-katanya sendiri informasi yang staf bagi atau meminta pasien menunjukkan keterampilan yang diajarkan.
 - f. Menahan diri dari menanyakan pada pasien, “Apakah anda mengerti?” untuk mengevaluasi pemahaman. Terlepas dari kemampuan mereka untuk memahami informasi, banyak orang yang tidak mengerti mungkin masih menjawab “Ya”.
 - g. Gunakan instruksi pemulangan yang memenuhi kebutuhan keaksaraan kesehatan. Bahan harus ditulis pada level 5 atau tingkat membaca yang lebih rendah. Mempertimbangkan revisi materi tertulis untuk mengatasi kebutuhan keaksaraan kesehatan dari semua pasien. Gunakan tes baca, membagi informasi kompleks menjadi poin-poin, dan modifikasi huruf dokumen, tata letak, dan memperbaiki desain untuk lebih mudah dibaca.
 - h. Menggunakan bahan instruksi pemulangan, bila memungkinkan yang telah diterjemahkan dalam bahasa yang paling sering ditemui di rumah sakit. Bahkan jika rumah sakit menyediakan bahan terjemahan, masih diperlukan untuk menyediakan penerjemah untuk bahasa pilihan pasien selama diskusi instruksi.
 - i. Jika memungkinkan, tanyakan pasien jika ia mendapat manfaat dari tindak lanjut panggilan telepon, untuk meninjau instruksi pemulangan dan mengajukan pertanyaan tambahan.
 - j. Memberikan nomor telpon rumah sakit yang sesuai pada pasien atau keluarga dan mendorong mereka untuk menelpon jika mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka setelah pemulangan.
4. Identifikasi Tindak Lanjut Penyedia yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Khusus Pasien.
- Saat rumah sakit memindahkan pasien ke fasilitas pengobatan lain (misalnya, panti jompo, rumah sakit, pusat rehabilitasi), staf harus memberitahu fasilitas kebutuhan khusus pasien untuk memastikan organisasi penerima dapat mengatur pelayanan dan akomodasi yang sesuai. Berbagi informasi tentang komunikasi, budaya, agama, spiritual, mobilitas, atau kebutuhan lain untuk membantu dalam transisi dan memudahkan penyesuaian ke fasilitas baru.
- a. Buat daftar dari tindak lanjut penyedia yang menawarkan layanan dan akomodasi yang sesuai untuk memenuhi komunikasi, budaya, agama atau spiritual, mobilitas, atau kebutuhan-kebutuhan pasien lainnya.
 - b. Mengidentifikasi penyedia layanan kesehatan yang sensitif mengenai pasien dan keluarga lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Asosiasi Medis Gay dan Lesbian menyediakan direktori online LGBT yang tersedia di <http://www.glma.org>.

- c. Merujuk pasien yang membutuhkan pengobatan tindak lanjut ke penyedia (misalnya, organisasi rumah kesehatan, komunitas klinik, penyedia pengobatan primer, rumah medis). Jika memungkinkan, staf harus mengatur pertemuan antara pasien dan menindaklanjuti layanan penyedia sebelum pemulangan.
- d. Mengidentifikasi pelayanan sosial yang tersedia dalam masyarakat, dan merujuk pasien bila diperlukan. Menyediakan pasien brosur lembaga pelayanan sosial, bila memungkinkan.
- e. Memastikan bahwa tindak lanjut penyedia untuk pasien yang memerlukan bantuan mobilitas memiliki peralatan khusus yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan dan tes, misalnya rumah sakit harus memastikan bahwa penyedia terapi fisik dianjurkan memiliki peralatan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pasien.

2.2.16 Edukasi Anestesi dan Bedah

1. Informasi Anestesi Umum (*General Anesthesia*)

Anestesi umum (*general anesthesia*) adalah prosedur pembiusan dengan cara pasien dibius seluruh tubuh (total) sehingga pasien tidak sadar dan tidak merasa nyeri selama operasi berlangsung. Anestesi umum dilakukan setelah pasien dipasang monitor dan dilakukan evaluasi ulang, obat anestesi disuntikkan lewat infus yang telah dipasang sebelumnya atau obat anestesi yang berupa uap/gas dihirup (*inhalasi*). Obat tersebut akan menimbulkan rasa mengantuk dan kemudian tertidur. Setelah pasien tertidur akan dilakukan pemasangan alat pembebas jalan napas lewat mulut/ hidung dan proses persiapan untuk tindakan operasinya dimulai dan selanjutnya operasi dilaksanakan. Pasien akan tidur dalam sampai operasi selesai dilakukan.

Setelah operasi selesai, obat anestesi dihentikan dan alat pembebas jalan nafas dilepas, pelan-pelan kesadaran akan kembali. Pasien akan dibangunkan dengan dipanggil namanya, bila sudah mulai bangun pasien akan berusaha untuk membuka mata. Saat bangun yang mungkin dirasakan adalah dingin, berat membuka mata, rasa panas di daerah operasi, mual, dan mungkin muntah. Rasa dingin yang dirasakan dikarenakan kamar operasi yang dingin ataupun cairan yang dipakai selama operasi dingin, pasien akan diberikan selimut hangat dan penghangat setelah keluar dari kamar operasi. Rasa berat untuk membuka mata dikarenakan sisa obat anestesi masih ada dalam sistem tubuh, sehingga pasien harus istirahat dan pelan-pelan sisa obat anestesi akan keluar dari sistem tubuh. Bila saat bangun rasa panas atau nyeri dirasakan pada tempat operasi, segera beritahu perawat agar obat analgetik tambahan diberikan lagi untuk mengurangi rasa nyeri tersebut. Obat untuk mual dan muntah sebenarnya telah diberikan untuk mencegah insiden PONV (*Postoperative Nausea Vomiting*) tetapi responnya tergantung individual pasien. Keluhan yang juga mungkin timbul adalah nyeri telan, suara serak atau parau, sehingga sangat dianjurkan untuk perbanyak minum air putih hangat untuk mengurangi keluhan.

Obat anestesi umum (*general anesthesia*) akan masuk ke seluruh sistem tubuh sehingga seluruh bagian tubuh terkena efek dari obat tersebut. Sebagian besar obat tersebut akan menimbulkan efek antara lain penurunan tekanan darah, penurunan frekuensi nafas, dan pada ibu hamil obat tersebut akan masuk ke aliran darah janin dimana hal tersebut akan diatur, dan diperbaiki oleh dokter anestesi. Alergi/hipersensitif terhadap obat juga bisa terjadi meskipun sangat jarang. Kesulitan pemasangan alat pembebasan jalan nafas tidak terduga sebelumnya yang dapat mengakibatkan gigi patah, trauma jalan nafas dan atau sariawan. Pada pasien dengan kondisi tertentu (antara lain penyakit jantung, ginjal, terinfeksi berat, kondisi tidak stabil) efek obat anestesi umum bisa menimbulkan henti jantung bahkan kematian, Komplikasi dapat timbul tanpa diduga sebelumnya dan akan ditangan sesuai prosedur medis yang berlaku. Anestesi umum (*general anesthesia*) bisa dilakukan pada semua jenis operasi antara lain kepala, leher, dada, perut bagian atas, dan operasi tangan/kaki/ penentuan tindakan dilakukan oleh dokter anestesi dengan mempertimbangkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pasien, operasi, dan dokter.

2. Informasi Anestesi Regional (Spinal/Epidural)

Anestesi regional (spinal/epidural) adalah prosedur pembiasan dengan menghilangkan sensasi bagian bawah tubuh mulai dari perut sampai ke ujung kaki dengan cara menyuntikkan obat di punggung dengan tujuan untuk merendam akar saraf yang terletak di sumsum tulang belakang sehingga sensasi nyeri dan fungsi otot di bagian tubuh bawah hilang untuk sementara. Setelah pasien dipasang monitor dan dievaluasi ulang, sehingga pasien diposisikan tidur miring ke kiri/kanan atau duduk dan melengkungkan badan semaksimal mungkin untuk memudahkan prosedur penyuntikan. Punggung pasien dibersihkan dengan cara betadine dan alkohol, dan dilakukan penyuntikkan untuk anestesi lokal dan selanjutnya obat anestesi akan disuntikkan menggunakan jarum khusus. Pada anestesi regional spinal obat disuntikkan dengan jarum yang kecil/halus, sedangkan pada anestesi regional epidural digunakan jarum yang sedikit lebih besar dengan atau tanpa memasang selang kateter. Adakalanya diberikan anestesi lokal agar saat penyuntikan dengan jarum spinal/epidural tidak nyeri. Saat penyuntikan jarum spinal ada kalanya terasa seperti tertetrum di punggung sampai ke kaki.

Efek samping yang dapat terjadi setelah obat dimasukkan di kaki akan terasa hangat menjalar ke perut kemudian kesemutan sebentar dan kemudian rasa hilang kaki sampai perut. Akan timbul perasaan kaki seperti tidak lurus atau posisi tidak begitu nyaman tapi itu hanya sensasi palsu karena sebenarnya posisi operasi kaki harus lurus dan nyaman. Pada operasi *Sectio Caesarea*, ada kalanya nafas terasa berat setelah obat dimasukkan, yang harus dilakukan adalah tarik napas (hirup lewat hidung dan keluarkan lewat mulut pelan-pelan) dan atur napas. Setelah bayi dikeluarkan keluhan napas berat akan hilang. Bila mengalami kesulitan menelan ludah dan tidak bisa bernapas, jangan panik, beritahu dokter anestesi. Dokter akan membantu memberi napas, begitu bayi dikeluarkan keluhan tersebut akan hilang. Bila terasa mual selama operasi, tarik napas panjang dan atur napas (hirup lewat hidung dan keluarkan lewat mulut pelan-pelan). Bila ada muntahan di mulut keluarkan ke samping, akan ada tempat untuk menampung muntahan dan jangan memancing untuk mengeluarkan muntahan (“hoek hoek”).

Efek obat anestesi regional spinal akan hilang setelah 2-4 jam, sedangkan obat anestesi regional epidural yang menggunakan selang kateter dan ditambah sesuai kebutuhan. Proses habisnya efek obat tersebut ditandai dengan bekas operasi mulai terasa hangat dan kadang-kadang panas terutama bila digerakkan (dimiringkan, batuk). Bila saat diam terasa nyeri sekali, beritahu perawat agar diberikan obat analgesik tambahan. Efek samping saat penyuntikan antara lain sesuai seperti tertetrum di punggung sampai kaki. Setelah operasi mungkin keluhan yang mungkin timbul adalah nyeri punggung bekas penyuntikan, pusing, dan kesemutan. Yang harus dilakukan adalah memberitahu perawat tentang keluhan yang muncul sehingga bisa diberikan obat untuk meredakan nyeri dan kesemutan. Mual, muntah, gatal-gatal, dan menggigil bisa terjadi yang disebabkan oleh efek obat anestesi regional. Alergi/hipersensitif terhadap obat bisa terjadi mulai derajat ringan sampai berat meskipun jarang terjadi.

Risiko dan komplikasi yang dapat terjadi diantaranya yaitu efek akar saraf di sumsum belakang yang diredam oleh obat anestesi yang diberikan bisa memanjang efeknya sehingga waktu yang diperlukan untuk pulih seperti sebelumnya lebih lama dan mungkin bisa lebih lama lagi jika memang sebelumnya sudah ada keluhan misalnya kesemutan, tebal atau tidak terasa yang terus-menerus. Anestesi regional dapat dilakukan pada operasi perut bagian bawah, kandungan, saluran kencing, prostat, dan kaki. Penentuan tindakan dilakukan oleh dokter anestesi dengan mempertimbangkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pasien & dokter.

3. Informasi Pemberian Obat Anti Nyeri Pasca Operasi

Menurut *International Association for Study of Pain* (IASP) nyeri adalah pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan jaringan/organ tubuh. Nyeri adalah suatu hal yang bersifat subyektif, sehingga tingkat nyeri yang dirasakan

bersifat individual. Nyeri pasca operasi umumnya merupakan nyeri akut yang disebabkan karena adanya kerusakan jaringan dan dapat menghilang seiring dengan penyembuhan jaringan tersebut. Nyeri akut biasanya hilang setelah beberapa jam hingga beberapa hari. Jika nyeri pasca operasi tidak diatasi maka pasien akan mengeluhkan nyeri yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan, nafas menjadi cepat, tekanan darah dan denyut nadi meningkat, tidak mau bergerak sehingga menyebabkan tubuh menjadi bengkak penyembuhan luka menjadi lambat. Tingkat intensitas nyeri dapat ditentukan dari lokasi operasi, besar/panjang irisan dan besarnya kerusakan jaringan.

Terdapat 2 pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri yaitu pendekatan non farmakologi dengan latihan nafas dalam, relaksasi, kompresi panas dingin, hipnoterapi, dan akupunktur. Pendekatan kedua yaitu pendekatan farmakologi dengan pemberian obat-obatan baik secara minum, injeksi, atau teknik-teknik tertentu sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kasus dimana obat anti nyeri menimbulkan gejala alergi yang bersifat individual, sehingga jika ada riwayat alergi obat mohon diinformasikan kepada petugas.

2.3 Komunikasi Antar Tenaga Kesehatan Pemberi Asuhan (Antar PPA) di dalam dan Luar Rumah Sakit

2.3.1 Komunikasi Efektif Saat Konsul atau Pelaporan Nilai Kritis

1. Hasil kritis didefinisikan sebagai varian dari rentang normal yang menunjukkan adanya kondisi patologis yang berisiko tinggi atau mengancam nyawa, yang dianggap gawat atau darurat, dan mungkin memerlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kejadian yang tidak diinginkan.
2. Pemeriksaan diagnostic mencakup semua pemeriksaan seperti laboratorium, pencitraan/ radiologi, diagnostic jantung juga pada hasil pemeriksaan yang dilakukan di tempat tidur pasien (*point of – care testing* (POCT))
3. Pada pasien rawat inap pelaporan hasil kritis dapat dilaporkan melalui perawat yang akan meneruskan laporan kepada DPJP yang meminta pemeriksaan.
4. Rentang waktu pelaporan hasil kritis ditentukan kurang dari 30 menit sejak hasil di verifikasi oleh PPA yang berwenang di unit pemeriksaan penunjang diagnostic.
5. Mekanisme pelaporan hasil kritis adalah sebagai berikut :
 - a. Dokter/ petugas laboratorium, radiologi dan perawatan yang melakukan pengecekan penunjang menyampaikan hasil kritis ke DPJP. Bila DPJP tidak bisa dihubungi, dokter/ petugas laboratorium, radiologi dan perawatan yang melakukan langsung menghubungi dokter/ perawat unit rawat inap, rawat jalan dan unit gawat darurat.
 - b. Dokter/ petugas yang melaporkan hasil kritis mencatat tanggal dan waktu menelpon, nama lengkap petugas kesehatan yang dihubungi dan nama lengkap yang menelepon di buku pelaporan hasil kritis.
 - c. Dokter/ perawat ruangan yang menerima hasil kritis menggunakan teknik menulis – membacakan – konfirmasi kembali, proses pelaporan ini ditulis di dalam rekam medis (form catatan perkembangan terintegrasi). Sedangkan petugas laboratorium atau radiologi menulis di buku pelaporan hasil kritis.
 - d. Dokter/ perawat ruangan yang menerima laporan hasil kritis langsung menghubungi DPJP yang merawat pasien.
 - e. Dokter/ perawat ruangan yang menerima laporan hasil kritis dan menghubungi DPJP yang merawat pasien harus mencatat tindakan yang diambil untuk pasien atau informasi lain terkait klinis
 - f. Semua hasil kritis/ interpretasi selanjutnya disampaikan melalui formulir hasil pemeriksaan sesuai dengan SPO Penyerahan Hasil.
 - g. Untuk pasien rawat jalan, hasil kritis harus dilaporkan kepada dokter yang meminta pemeriksaan dan harus menyampaikan hasil kritis ke pasien.

- h. Dokter yang dilaporkan tentang hasil kritis yang perlu diwaspadai tersebut, bertanggung jawab terhadap interpretasi hasil dan pengambilan tindakan terhadap pasien

2.3.2 Timbang Terima (*Hand Over*)

1. Metode komunikasi saat serah terima distandarisasi pada jenis serah terima yang sama antar ruangan rawat inap. Jika antar ruangan yang berbeda, misalkan dari IGD ke ruang rawat inap dapat menggunakan metode, formulir dan alat yang berbeda.
2. Jenis serah terima di dalam rumah sakit dapat mencakup :
 - a. Antar PPA (misalnya, antar dokter, dari dokter ke perawat, antar perawat, dan seterusnya)
 - b. Antar unit perawatan yang berbeda di dalam rumah sakit (misalnya saat pasien dipindahkan dari ruang perawatan intensif ke ruang perawatan atau dari instalasi gawat darurat ke ruang operasi), dan
 - c. Dari ruang perawatan pasien ke unit layanan diagnostic seperti radiologi atau fisioterapi.
3. PPA mencatat serah terima di formulir atau di buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan di dalamnya ada kepada siapa tanggung jawab pelayanan diserahkan, kemudian juga ada tanda tangan, tanggal dan waktu pencatatan.

2.3.3 Singkatan Terstandart

Penggunaan singkatan-singkatan yang tidak ditetapkan oleh rumah sakit sering kali menimbulkan kesalahan komunikasi dan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, rumah sakit diminta memiliki daftar singkatan yang diperkenankan dan dilarang. Untuk istilah yang sulit atau obat-obatan kategori LASA (*Look Alike Sound Alike*) diminta penerima pesan mengeja kata tersebut per huruf,misalnya: UBRETID.

Tabel 2.5 Kode alfabet internasional yang digunakan dalam mengeja huruf

A= alfa	H = hotel	O= Oscar	V= victor
B= bravo	I= India	P = papa	W = whiskey
C= Charlie	J= Juliet	Q= quebec	X= Xray
D= delta	K= Kilo	R= romeo	Y = Yankee
E=echo	L= lima	S = Sierra	Z= zulu
F=Fanta	M= mama	T= tango	
G=Golf	N= november	U= uniform	

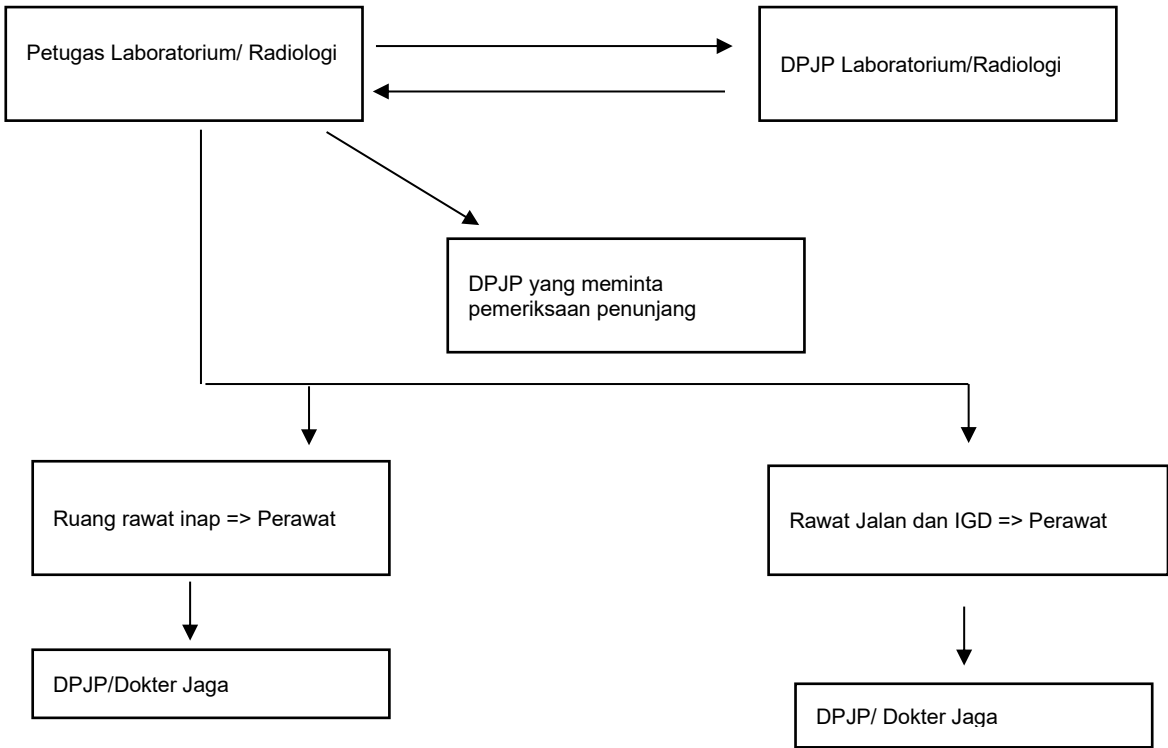
2.3.4 Alur Pelaporan Untuk Nilai Kritis Dan Diagnostik Kritis

Hasil kritis didefinisikan sebagai varian dari rentang normal yang menunjukkan adanya kondisi patologis yang berisiko tinggi atau mengancam nyawa, yang dianggap gawat atau darurat, dan mungkin memerlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kejadian yang tidak diinginkan.

Nilai kritis adalah pelaporan dari hasil laboratorium yang kritis adalah bagian dari risiko terkait keselamatan pasien. Pelaporan dari hasil laboratorium yang kritis adalah bagian dari risiko terkait keselamatan pasien. Hasil laboratorium yang secara signifikan diluar batas nilai normal dapat memberi indikasi risiko tinggi atau kondisi yang mengancam kehidupan pasien. Sangat penting bagi rumah sakit untuk mengembangkan suatu sistem pelaporan formal yang jelas menggambarkan bagaimana profesional pemberi asuhan (PPA) mewaspadai hasil laboratorium yang kritis dan bagaimana staf mendokumentasikan komunikasi ini.

Proses ini dikembangkan rumah sakit untuk pengelolaan hasil laboratorium yang kritis sebagai pedoman bagi profesional pemberi asuhan (PPA) ketika meminta dan menerima hasil laboratorium pada keadaan gawat darurat.

Alur Pelaporan Hasil Kritis



Gambar 2.3 Alur Pelaporan Hasil Kritis

Keterangan :

1. 10 menit pertama adalah pelaporan dari Laboratorium/ radiologi ke DPJP yang meminta pemeriksaan sejak ditemukannya hasil kritis dan sudah dikonfirmasi oleh dokter penanggung jawab Laboratorium atau radiologi.
2. 10 menit kedua adalah bagian Laboratorium/ Radiologi melaporkan kepada perawat di ruangan sesuai dengan unit yang meminta
3. 10 menit selanjutnya adalah perawat unit melaporkan kepada DPJP terkait dan mendokumentasikan di formulir catatan perkembangan pasien (CPPT)
4. Semua wajib dilaporkan maximal 30 menit dari waktu ditemukannya hasil kritis dan sudah dikonfirmasi oleh dokter penanggung jawab Laboratorium atau radiologi.

Hasil laboratorium yang secara signifikan diluar batas nilai normal dapat memberi indikasi risiko tinggi atau kondisi yang mengancam kehidupan. Pencapaian hasil laboratorium nilai kritis dilaporkan oleh analis yang bertugas yang dilaporkan kepada perawat, dan didokumentasikan di buku nilai kritis dan di dokumen rekam medis pasien.

Tabel 2.6 Daftar Rentang Nilai Kritis Pemeriksaan Laboratorium RS Prima Husada

No	Tes Pemeriksaan	Nilai Kritis	Satuan
1	Hematologi		
	HCT	< 20 atau > 60	%
	Hb	< 7 atau > 20	g/dl
	Trombosit Dewasa	< 40.000 atau > 1.000.000	10 ³ /ul
	Leukosit	< 2.000 atau > 30.000	10 ³ /ul
	APTT	> 100	Detik
	PPT	> 30 atau > 3x nilai kontrol	Detik
	Penemuan Sel Blast Di Hapusan Darah Tepi	-	-

	Penemuan Sel Asing Di Sumsum Tulang	-	-
2	Kimia Klinik		
	Troponin I	> 100	ng/dl
	CKMB	> 200	uL
	Glukosa	< 45 atau > 800	mg/dl
	Glukosa Neonatus	< 30 atau > 300	mg/dl
	Creatinin	> 5,0	mg/dl
3	Natrium		
	Kalium	< 2,8 atau > 6,2	mmol/L
	Kalium Neonatus	< 2,5 atau > 8,0	mmol/L
	Natrium	< 120 atau > 160	mmol/L
4	Cairan Tubuh (Pleura, Serebrospinal, Asites)		
	Glukosa	< 80 Kadar glukosa darahnya	%
	Total Protein	> 45	mg/dl
	Leukosit	> 10	/ul
	Pengecatan Bakteri	(+)	-
	Ditemukan Sel Asing		-
5	Urinalisa		
	Glukosaria	> 2+	
	Keton	> 2+	
	Ditemukan Kristal Patologis	Uric Acid, Sistein, Leusin, Tirosin	
	Albuminaria	> 2+	
	Eritrosit	> 2+	
	Leukosit	> 2+	

Tabel 2.7 Daftar Rentang Hasil Diagnostik Kritis Pemeriksaan Radiologi RS Prima Husada

No	Pemeriksaan	Posisi	Hasil Kritis
1	Skull	AP Lateral	1. Open Fraktur Os Cranium 2. Open Fraktur Os Mandibula 3. Open Fraktur Os Temporalis (Epidural Hematome) 4. Cerebral Infarct 5. COB
2	Cervical	AP Lateral Oblique	Open Fraktur Os Cervical
3	Shoulder	AP	1. Open Fraktur Hip Joint Humerus 2. Dislokasi Shoulder
4	Clavicula	AP	Open Fraktur Os Clavicula
5	Thorax	AP Lateral	1. Open Fraktur Costae > 2 Costae Yang Sama (Open, Closed, Tension) 2. Hematothorax/Pneumothorax
6	Humerus	AP Lateral	Open Fraktur Os Humerus 1/3 Distal
7	Antebrachii	AP Lateral	1. Open Fraktur Os Radius 2. Open Fraktur Os Ulna 3. Dislokasi Elbow 4. Dislokasi Wrist
8	Manus	AP Oblique	1. Open Fraktur Os Metacarpal 2. Open Fraktur Os Carpal 3. Dislokasi Dip 4. Dislokasi Pip
9	Abdomen	AP	Trauma
10	Pelvis	AP	1. Dislokasi Hip Joint 2. Syok Hipovolemia Merobek Arteri Abdominalis
11	Femur	AP Lateral	Open Fraktur Os Femur
12	Cruris	AP Lateral	1. Open Fraktur Os Tibia 2. Open Fraktur Os Fibula 3. Dislokasi Knee Joint
13	Pedis	AP Oblique	1. Open Fraktur Os Metatarsal 2. Open Fraktur Os Tarsal
14	Lumbal	AP Lateral	Spondilolistesis
15	Ankle	AP Oblique	Dislokasi Ankle
NO	PEMERIKSAA N	POSISI	HASIL KRITIS
11	FEMUR	AP LATERAL	OPEN FRAKTUR OS FEMUR
12	CRURIS	AP LATERAL	OPEN FRAKTUR OS TIBIA OPEN FRAKTUR OS FIBULA DISLOKASI KNEE JOINT
13	PEDIS	AP OBLIQUE	OPEN FRAKTUR OS METATARSAL OPEN FRAKTUR OS TARSAL

14	LUMBAL	AP LATERAL	SPONDILOLISTESIS
15	ANKLE	AP OBLIQUE	DISLOKASI ANKLE

Tabel 2.8 Daftar Rentang hasil diagnostik kritis Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) RS Prima Husada

No	Pemeriksaan	Hasil Kritis
1	Skull	Intracerebral Hematoma (Ich)
2	Thorax	Trauma Thorax
3	Abdomen	Trauma Abdomen Pada Intra Peritoneum Acute Appendicitis
4	Mammae	Stenosis Mammae Pada Arteri Mammaria
5	Thyroid	Thyroid Dengan Trauma Pada Neck

Tabel 2.9 Daftar Rentang hasil diagnostik kritis Pemeriksaan CT Scan

No	Pemeriksaan	Hasil Kritis
1	Skull	Intracerebral Hematoma (Ich)
2	Thorax	Trauma Thorax
3	Abdomen	Trauma Abdomen Pada Intra Peritoneum

- 2.3.5 Komunikasi Antar Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Dan Staf Klinis
- Komunikasi Antar Staf klinis dan PPA dapat dilakukan sebagai berikut:
- Antar Pelayanan Klinik dan Non-Klinik

Komunikasi dilakukan melalui transfer antar ruang, hand over antar shift berguna untuk menyampaikan segala hal maupun masalah yang terjadi di dalam shift dan antar shift jaga.
 - Antar Unit Pelayanan (IGD ke RI/ ICU,RI ke ICU dan ICU ke RI)

Pasien sering berpindah (transfer) pelayanan di rumah sakit. Saat perpindahan pasien maka terjadi juga perpindahan tim pelayanan. Perpindahan pasien dari satu tim pelayanan ke tim pelayanan yang lain harus diikuti oleh perpindahan informasi kesehatan pasien. Alat komunikasi pasien antar tim pelayanan adalah rekam medis atau ringkasannya . Ringkasan transfer Rekam medis sebagai sarana komunikasi transfer pasien mengandung :

 - Alasan masuk rumah sakit
 - Temuan yang signifikan
 - Diagnosis yang telah ditegakkan
 - Tindakan yang telah diberikan
 - Obat-obatan yang telah diberikan
 - Kondisi pasien saat dipindah
 - Kelengkapan berkas saat dipindah
 - Antar DPJP dengan DU (Dokter Umum)

 - Pelayanan medis di RS PRIMA HUSADA MALANG dilaksanakan oleh dokter spesialis dan dokter umum.
 - Dokter umum mengkonsulkan kondisi pasien dan mengarahkan ke DPJP sesuai kompetensi.

-
- c. Jika karena suatu sebab dokter spesialis tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka yang bersangkutan wajib melapor kepada atasan dan mendelegasikan tugas-tugas kepada dokter spesialis di lingkungan SMF-nya.
 - d. Apabila di suatu SMF hanya ada satu orang dokter spesialis atau jika semua dokter spesialis di suatu SMF berhalangan hadir (tugas), maka Kepala SMF wajib mendelegasikan tugas-tugas pelayanan kesehatan kepada dokter umum (dokter jaga ruangan), sesuai dengan kompetensinya yang ditentukan oleh dokter spesialis yang bersangkutan.
4. Antar Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)
- a. Pelayanan medis di RS Prima Husada Malang dilaksanakan oleh dokter spesialis dan dokter umum.
 - b. Jika oleh karena suatu sebab dokter spesialis tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka yang bersangkutan wajib melapor kepada atasan dan mendelegasikan tugas-tugas kepada dokter spesialis di lingkungan SMFnya.
 - c. Apabila di suatu SMF hanya ada satu orang dokter spesialis atau jika semua dokter spesialis di suatu SMF berhalangan hadir (tugas), maka Kepala SMF wajib mendelegasikan tugas-tugas pelayanan kesehatan kepada dokter umum (IGD atau dokter ruangan), sesuai dengan kompetensinya yang ditentukan oleh dokter spesialis yang bersangkutan.
 - d. Pada kasus tertentu baik dari rawat jalan maupun rawat inap yang memerlukan pengelolaan medis oleh lebih dari satu DPJP/bidang SMF lain sesuai dengan kewenangan klinisnya, DPJP utama wajib melakukan konsultasi dalam hal:
 - 1) Konsultasi Minta Pendapat
Apabila hanya diperlukan untuk memperoleh informasi dan pertimbangan dari SMF lain tanpa mendapat penanganan lanjutan dari SMF tersebut.
 - 2) Konsultasi Alih Rawat
Dilakukan apabila suatu kasus yang awalnya dirawat oleh suatu SMF dan ternyata sudah tidak perlu mendapatkan perawatan dari SMF tersebut, sedangkan lebih tepat dirawat oleh SMF lain
 - 3) Konsultasi Rawat Bersama
Apabila terdapat kasus yang bersifat kompleks dan harus mendapat penanganan lebih dari satu bidang ilmu/SMF dengan DPJP Utama adalah bidang SMF yang tingkat kegawatannya paling tinggi. Segala bentuk informasi antar DPJP dituangkan dalam form konsultasi yang tersedia dan diletakkan dalam les pasien. Segala perihal keperluan konsultasi antar DPJP harus dijelaskan kepada pasien mengenai maksud dan tujuannya.
5. Antar DPJP dengan perawat
- a. Pelayanan medis di RS PRIMA HUSADA MALANG dilaksanakan oleh dokter spesialis, dokter umum dan pelayanan keperawatan oleh perawat.
 - b. Perawat IGD, poliklinik dan ruangan wajib melaksanakan instruksi dari DPJP dalam pemberian pelayanan medis pasien yang ditulis form perkembangan penyakit pasien.
 - c. Segala tindakan yang dilakukan oleh perawat atas instruksi DPJP harus tercatat dalam form tindakan keperawatan dan apabila terjadi sesuatu pada pasien setelah diberikan tindakan segera dan perawat harus wajib melaporkan ke DPJP yang merawat.
6. Antar Dokter Jaga dan Perawat Jaga (Shift jaga)

- a. Perawat jaga menginformasikan jumlah pasien.
 - b. Perawat jaga melaporkan permasalahan yang ada.
 - c. Perawat jaga melaporkan pasien-pasien yang bermasalah.
7. Antar Shift Pendaftaran dan Shift Kasir
- a. Shift sebelumnya menjelaskan keadaan secara umum.
 - b. Shift sebelumnya menjelaskan permasalahan selama jaga.
 - c. Shift sebelumnya menjelaskan instruksi yang terbaru dari atasan.

Metode komunikasi efektif dapat dilakukan dengan metode yang disebut SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*). Komunikasi efektif SBAR dapat diterapkan oleh semua tenaga kesehatan. Bukti komunikasi melalui telepon tersebut dapat berupa tulisan yang didokumentasikan pada catatan perkembangan pasien terintegrasi di dokumen rekam medis. Harapan adanya bukti penulisan tersebut komunikasi dapat didokumentasikan dengan baik dan terintegrasi sehingga antar tenaga kesehatan lain dapat mengetahui perkembangan pasien.

Berikut contoh penjelasan komunikasi efektif menggunakan metode SBAR pada Tabel 5.1

Tabel 2.10 Komunikasi Efektif antar semua tenaga kesehatan menggunakan metode SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*)

No.	Metode SBAR	Penerapan antar shift dinas/serah terima pasien	Penerapan antara perawat dengan dokter lewat telepon
1.	<i>Situation :</i> Bagaimana situasi yang akan dibicarakan/ dilaporkan? 1. Mengidentifikasi nama diri petugas dan pasien 2. Diagnose medis 3. Apa yang terjadi dengan pasien	1. Nama : Tn. X, usia 35 tahun, tanggal masuk 10 Juli 2025 sudah 3 hari perawatan 2. DPJP : dr. X SP. PD, diagnosis : Gagal Ginjal Kronik 3. Masalah keperawatan : Hipervolemia dan Nausea	1. Selamat pagi dokter, saya perawat S dari Irna 3A 2. Melaporkan pasien atas nama Tn. X mengalami penurunan pengeluaran urin 40 cc/24 jam, mengalami sesak
2.	<i>Background :</i> Apa latar belakang informasi klinis yang berhubungan dengan situasi? 1. Obat saat ini dan alergi 2. Tanda – tanda vital terbaru 3. Hasil laboratorium/ radiologi : tanggal dan waktu tes dilakukan dan	1. Pasien bedrest total, urine 50 cc/24 jam, balance cairan 1000cc/ 24 jam. 2. Mual tetap ada selama dirawat, ureum 300 mg/dl. 3. Pasien program HD 2x seminggu Senin dan Kamis. 4. Terpasang infus NaCl 10 tetes/menit 5. Dokter sudah menjelaskan	1. Diagnosa medis gagal ginjal kronik, tanggal masuk 10 Juli 2025, program HD hari Senin - Kamis. 2. Tindakan yang sudah dilakukan posisi semi fowler, sudah terpasang dower kateter, pemberian oksigen 3 liter/menit 15 menit yang lalu.

No.	Metode SBAR	Penerapan antar shift dinas/serah terima pasien	Penerapan antara perawat dengan dokter lewat telepon
	hasil tes sebelumnya untuk perbandingan 4. Riwayat medis 5. Temuan hasil klinis terbaru	penyakitnya tentang gagal ginjal kronik 6. Diet : rendah protein 1 gram	3. Obat injeksi diuretic furosemide 3 x 1 amp 4. TD 150/80 mmHg, RR 30x/menit, Nadi 100 x/menit, edema ekstremitas bawah dan asites 5. Hasil laboratorium terbaru : Hb 9 mg/dl, albumin 3, ureum 300 mg/dl 6. Kesadaran compos mentis, bunyi nafas rhonki +.
3.	<i>Assessment :</i> Berbagai hasil penilaian klinis perawat 1. Apa temuan klinis? 2. Apa analisis dan pertimbangan perawat?. 3. Apakah masalah ini parah atau mengancam kehidupan?	1. Kesadaran compos mentis, TD 150/80 mmHg, Nadi 100x/menit, suhu 37°C, RR 20x/menit, edema pada ekstremitas bawah, tidak sesak napas, urine sedikit, eliminasi feses baik 2. Hasil laboratorium terbaru : Hb 9 mg/dl, albumin 3, ureum 300 mg/dl 3. Pasien masih mengeluh mual	1. Saya pikir masalahnya adalah hipervolemia dan Nausea 2. Pasien tampak tidak stabil
4.	<i>Recommendation :</i> Apa yang perawat inginkan terjadi dan kapan? 1. Apa tindakan /rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki masalah? 2. Apa solusi yang bisa perawat tawarkan kepada dokter? 3. Apa yang perawat butuhkan dari dokter untuk memperbaiki kondisi pasien?	1. Awasi balance cairan 2. Batasi asupan cairan 3. Konsul ke dokter untuk pemasangan dower kateter 4. Pertahankan pemberian pemberian diuretic injeksi furosemide 3x 1 amp 5. Bantu pasien memenuhi kebutuhan dasar pasien 6. Jaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur	1. Haruskah saya mulai dengan pemberian oksigen NRBM? 2. Apa advise dokter? Perlukah peningkatan diuretic atau syringe pump? Apakah dokter akan memindahkan pasien ke ICU?

No.	Metode SBAR	Penerapan antar shift dinas/serah terima pasien	Penerapan antara perawat dengan dokter lewat telepon
	4. Kapan waktu yang perawat harapkan tindakan ini terjadi?		

Tata cara komunikasi dengan metode SBAR sebagai berikut:

- (1) Pemberi pesan secara lisan memberikan pesan, setelah itu dituliskan secara lengkap isi pesan tersebut Write Back/ tulis lengkap di singkat (TUL) oleh si penerima pesan.
- (2) Isi pesan dibacakan ulang Read Back/ baca ulang disingkat (BA) secara lengkap oleh penerima pesan. Dengan tujuan untuk mengkonfirmasi kebenaran perintah atau advis atau terapi.
- (3) Beri tanda (√) pada instruksi, nama obat atau hasil pemeriksaan yang sudah dibacakan ulang tersebut, jika pemberi order atau pemberi informasi telah menyatakan “ya”/ketepatan pengulangan.
- (4) Perintah/advis/ terapi atau hasil pemeriksaan kritis dikonfirmasi (confirm) atau konfirmasi ulang disingkat (KON) oleh individu yang memberikan perintah. Dengan menggunakan stempel konfirmasi SBAR dalam waktu 1 X 24 jam
- (5) Konsul atau pelaporan kondisi pasien atau hasil pemeriksaan penunjang medis yang mempunyai nilai kritis wajib menggunakan media telepon.
- (6) Konsul atau pelaporan kondisi pasien atau hasil pemeriksaan penunjang medis yang tidak mempunyai nilai kritis tetapi abnormal bisa menggunakan media telepon atau media sosial lain (SMS, WA, Telegram, dll).
- (7) Apabila konsul atau pelaporan melalui media social lain (SMS,WA, Telegram, dll) dalam waktu 30 menit belum mendapat tanggapan atau balasan, maka konsul atau pelaporan wajib melalui telepon.
- (8) Konsul atau pelaporan yang menggunakan media sosial (SMS, WA,Telegram,dll) untuk memastikan advis yang diberikan sudah sesuai dan benar maka advis yang diberikan dicatat di CPPT kemudian difoto dan dikirim ke pemberi perintah.
- (9) Beri tanda centang (√) pada advis yang diberikan, apabila pemberi perintah sudah menyatakan benar.
- (10)Konsul atau pelaporan yang menggunakan media sosial, maka bukti komunikasi berupa percakapan tidak boleh dihapus sampai sudah dilakukan konfirmasi oleh pemberi perintah.
- (11)Handphone PPA harus selalu aktif (nada dering, notifikasi medsos)
Apabila ada PPA (DPJP) memberikan perintah atau advis melalui telepon atau media sosial lain (SMS, WA, Telegram,dll) tanpa didahului konsul dari ruangan maka advis yang diberikan dicatat di CPPT tanpa menggunakan format SBAR.

2.3.6 Persyaratan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan asuhan dan pemberian tindakan sangat dipengaruhi oleh kompetensi Profesional Pemberi Asuhan (PPA), staf klinis, dan staf non klinis. Dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan adanya komunikasi efektif agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh pasien dengan baik. Untuk itu Profesional Pemberi Asuhan (PPA), staf klinis, dan staf non klinis harus memenuhi persyaratan dalam memberi tindakan. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dan staf klinis harus sudah terlatih komunikasi efektif dan edukator yang dapat dibuktikan dengan sertifikat kegiatan sedangkan staf non klinis harus terlatih komunikasi efektif.

2.3.7 Penetapan Informasi Tepat Dan Akurat

Informasi yang harus disampaikan secara akurat dan tepat ke seluruh rumah sakit termasuk yang “urgent”. Meliputi informasi sebagai berikut:

1. *Code Red* (Merah)

Code Red adalah kode yang mengumumkan adanya bahaya kebakaran di lingkungan rumah sakit.

Langkah-langkah :

- a. Terjadi kebakaran di ruangan, Tim *Code Red* ruangan berusaha memadamkan awal.
- b. Kalau teratasi melapor ke kepala ruang, pengamat, dan Tim *Code Red* Rumah sakit. Kalau tidak teratasi, mengaktifkan *Code Red*, dengan cara menelpon lobi informasi dengan nomor ext. 0. Lobi informasi menyampaikan *Code Red* di ruangan (...), lalu menghubungi koordinator tim *Code Red* Rumah Sakit
- c. Koordinator menghubungi regu pemadam, tim keamanan, front office, Tim *Code Red* Ruangan. Regu pemadam ke lokasi dan dibantu *Code Red* Ruangan untuk evakuasi pasien, alat medis dan dokumen.
- d. Tim keamanan menjaga keamanan lingkungan Rumah Sakit
- e. Bencana teratasi melapor pada koordinator *Code Red* di Rumah Sakit
- f. Tidak teratasi, koordinator *Code Red* menghubungi lobi informasi untuk memanggil tim PMK Kabupaten. Selesai pemadam semua tim (PMK, regu pemadam keamanan, Tim *Code Red* Ruangan melaporkan hasil kegiatannya ke koordinator.

2. *Code Blue* (Biru)

Code Blue adalah kode yang mengumumkan adanya pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan karyawan yang mengalami henti jantung dan membutuhkan tindakan resusitasi segera.

Langkah-langkah :

- a. Segera evakuasi korban dengan telaah bahaya yang dapat muncul segera, catat waktu, periksa tanda-tanda kehidupan (tidak ada respon, tidak bernafas normal atau tidak teraba nadi)
- b. Minta bantuan staf lainnya (teriak minta bantuan “*Code Blue*” atau gunakan bel yang tersedia. Telepon “0” yang akan meneruskan ke TIM CODE BLUE (IGD, OK, ICU, HCU) dengan menjelaskan jenis emergency, lokasi kejadian, nama, tugas dan nama tempat tugas.
- c. Tindak pasien dengan :
Check pernafasan, check nadi, bebaskan jalan nafas, dan lakukan tindakan emergency sesuai dengan yang diperlukan, misalnya Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR)
- d. Dampingi atau jaga terus pasien sampai bantuan datang

3. *Code Pink* (Merah muda)

Code Pink adalah kode yang mengumumkan adanya penculikan bayi/ anak atau kehilangan bayi/ anak di lingkungan rumah sakit.

Langkah-langkah:

- a. Jika diketahui atau dicurigai adanya pasien bayi/anak hilang SEGERA teriakkan *Code Pink*. Segera hubungi nomor telpon operator sentral RS (0) dan melaporkan tempat kejadian serta kejadian *code pink*.
- b. Batasi akses ke area kejadian. Security yang bertugas di ruangan/ gedung tempat kejadian segera menutup akses keluar masuk ruangan/ gedung. Periksa semua pengunjung (termasuk staf RS) yang akan keluar gedung terutama pengunjung yang membawa bayi, tas besar atau menggunakan jaket/ mantel.
- c. Operator kemudian akan mengumumkan *code pink* dan mengaktifkan tim *code*

- pink (petugas security). Petugas ruangan akan mengecek semua area di ruangan tersebut dan mengidentifikasi identitas pasien bayi/ anak yang hilang.
- d. Komandan Security kemudian menginstruksikan kepada jajarannya untuk menutup semua akses keluar masuk RS. Periksa semua pengunjung (termasuk staf RS) yang akan keluar RS terutama pengunjung yang membawa bayi, tas besar atau menggunakan jaket/ mantel.
 - e. Komandan security melaporkan kejadian ke polisi, Security segera menuju ke lokasi dan mengidentifikasi kejadian.
 - f. Keluarga diberikan ruangan yang tenang dan senantiasa ditemani staf. Tim code pink menyerahkan penanganan kasus segera setelah polisi datang. Polisi mengambil alih penanganan kejadian. Jika tidak ada Tim Code Pink di RS □ Security.

4. *Code Black* (Hitam)

Code black adalah sebuah pernyataan kondisi darurat terkait ancaman bom atau adanya informasi ancaman bom dan benda-benda yang dicurigai dan tidak dikenal. Langkah-langkah :

- a. Tindakan bila melihat atau menerima ancaman bom
 - 1) Teroris telpon, catat dan/atau rekam data penelepon, laporkan ke bagian keamanan/security RS Prima Husada Malang .
 - 2) Melihat benda yang dicurigai sebagai bom, catat lokasi keberadaan bom dan laporkan ke bagian keamanan/ security RS Prima Husada Malang , dan dilarang menyentuh benda tersebut.
 - 3) Menerima ancaman bom melalui surat, penerima surat menghubungi bagian keamanan/ security RS Prima Husada Malang
- b. Penemu Bom langsung melaporkan ke Bagian Keamanan/ security dan lobi informasi (Telp. Ext 0)
- c. Lobi informasi menginformasikan “Code Black” ke seluruh RS.
- d. Bagian Keamanan/security mengamankan area yang diduga terdapat bom, dengan memasang garis pengaman, untuk menghindari masyarakat Rumah Sakit masuk ke area yang diduga terdapat bom.
- e. Code black aktif, evakuasi seluruh penghuni gedung/ bangunan sesuai dengan SPO Code Black. Bom diamankan, pembuatan pelaporan dan selesai.
- f. Menghubungi pihak terkait (Tim Gegana dari Kepolisian) sesuai instruksi bagian Keamanan/ security. Jika situasi dinyatakan aman, penghuni gedung dapat memasuki gedung kembali. Dan jika tidak ada tim code black di RS □ Security.

5. *Code Green* (Hijau)

Code Green adalah kode yang mengumumkan adanya insiden yang terjadi di luar rumah sakit (*emergensi eksternal*) terkait gempa bumi.

Langkah-langkah :

- a. Siap-siaga pada Bencana Gempa Bumi:
 - Lakukan perkiraan bahaya di tempat anda, runtuhnya sesuatu menimbulkan kerugian selama dan sesudah gempa. Sangga atau ikat kabinet dan peralatan berat lainnya yang dapat jatuh atau menimpa sewaktu gempa bumi. Rencanakan prinsip dan alternatif rute evakuasi keluar dari gedung. Siapkan kabinet gempa bumi dengan obat-obatan, air dan makanan.
- b. Selama gempa bumi:
 - 1) Jika berada didalam gedung berlindunglah. Merunduk ke lantai dan berlindung di bawah obyek yang kokoh seperti meja tulis, meja kerja atau di bawah kusen pintu. Berlindunglah dan jauhilah dinding, jendela, partisi kaca dan perabot rumah atau obyek yang dapat menimpa anda.
 - 2) Jika berada diluar, berjongkoklah, lipat tangan sekitar lutut atau kencangkan tangan dibelakang leher, dan benamkan wajah ke pangkuan. Tutup mata dan

lindungi telinga dengan lengan bawah. Hindari gedung, saluran listrik, alat berat atau pohon yang dapat menimpa anda. Tetap tenang, jangan panik.

c. Setelah gempa bumi:

- 1) Setelah guncangan reda, tetap lindungi diri anda. Guncangan keras yang berikutnya dapat terjadi & menyebabkan kerusakan. Jika anda berada didalam gedung tetaplah didalam. Jika diluar tetaplah berada di tempat yang aman.
- 2) Bekerjasama dengan pegawai lainnya untuk mencari korban yang luka. Koordinator Pengamanan dan Kewaspadaan Bencana dan security gedung harus meneliti kemungkinan bahaya serta memutuskan atau mematikan saluran listrik dan gas di dalam gedung. Buka setiap pintu dengan hati-hati.
- 3) Gunakan telepon hanya untuk sesuatu yang bersifat darurat.
- 4) Jika kerusakan membahayakan & gedung harus dievakuasi, Koordinator Pengamanan & Kewaspadaan Bencana harus menentukan tempat, taman/area terbuka yang minim bahaya.
- 5) Ikuti petunjuk evakuasi, hindari bahaya yang disebabkan kerusakan oleh gempa bumi, seperti rusaknya saluran listrik.

2.3.8 Komunikasi Keluar Rumah Sakit (Rujukan)

Komunikasi efektif juga harus dilakukan saat melakukan rujukan, komunikasi dan informasi awal yang harus disampaikan sebelum pasien dirujuk adalah

1. Komunikasi dengan Rumah Sakit yang dirujuk terkait kondisi pasien.
2. Informasi *feedback* (timbal balik) dari Rumah Sakit yang dirujuk terkait kesediaan untuk menerima.
3. Informasi kelengkapan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani.
4. Rujukan edukasi ke FKTP, Komunitas dan RS rujukan

BAB III

KOMUNIKASI ANTARA PIMPINAN DAN STAF, MANAJEMEN DENGAN UNIT PELAYANAN DAN SEBALIKNYA.

3.1 Komunikasi Antar Tingkat Di Rumah Sakit

Para kepala bidang/divisi Rumah Sakit bertanggung jawab bahwa di seluruh tempat di rumah sakit terselenggara komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi antar kelompok profesional (komunikasi dalam komite), antar unit struktural (rapat koordinasi), antara profesional dan manajemen (rapat), juga profesional dengan organisasi di luar (seminar, workshop, diklat eksternal). Direktur Rumah Sakit memperhatikan akurasi dan ketepatan waktu penyampaian informasi ke seluruh tempat di rumah sakit. Direktur Rumah Sakit membentuk budaya kerjasama dan komunikasi untuk melakukan koordinasi serta integrasi asuhan pasien.

Metode secara formal seperti pembentukan komite atau tim gabungan dan informal seperti poster dan surat kabar digunakan untuk meningkatkan peran pentingnya komunikasi antara berbagai layanan dan anggota staf. Pengembangan koordinasi layanan klinik yang baik diperoleh karena ada pengertian dari setiap unit pelayanan untuk berkolaborasi menyusun kebijakan dan prosedur. Dalam mengembangkan komunikasi dan koordinasi yang baik, rumah sakit perlu mengatur pertemuan di setiap tingkat rumah sakit, misalnya pertemuan direksi, pertemuan para kepala bidang/bagian, dan pertemuan antar unit pelayanan. Selain itu, perlu pertemuan antar tingkat, misalnya pertemuan direksi dengan para kepala bidang/bagian dengan Kepala Unit Pelayanan. Rumah sakit perlu mengembangkan pertemuan antar profesi. Misalnya pertemuan dokter, perawat, dan PPA lain dalam membahas pengembangan pelayanan, *update* ilmu pengetahuan, skill dan keterampilan.

3.2 Etiket

3.2.1 Etiket Berkomunikasi Secara Langsung

1. Pada Senior

- Berusaha untuk menyapa terlebih dahulu.
- Berbicaralah dengan menggunakan kata-kata yang sopan, jelas, dan ramah.
- Berbicara dengan menggunakan intonasi suara yang sesuai, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat.
- Tidak mengeluarkan bunyi-bunyian atau gerakan yang tidak diperlukan.
Contoh : tidak menggoyangkan kaki, mengetukkan jari/pulpen, menggaruk-garuk kepala, mengunyah sesuatu, dll.
- Tidak memotong pembicaraan saat senior sedang berbicara, baik saat senior sedang berbicara dengan pasien ataupun dengan kita.
- Jika memungkinkan sebelum berbicara menggunakan kata "maaf".
- Menggunakan kata sapa seperti : bapak, ibu, dokter, mbak, dll. Lalu dilanjutkan dengan namanya jika kita mengetahui namanya.
- Berusaha untuk mempertahankan kontak mata, mendengarkan secara aktif, dan berusaha untuk menjawab jika diajukan suatu pertanyaan dengan singkat, jelas, dan tidak berbelit-belit.

2. Pada sesama

- Berusaha untuk menyapa terlebih dahulu.
- Berbicara dengan menggunakan kata-kata yang sopan, jelas, dan ramah.
- Tidak menggunakan kata sapa yang kurang sopan, seperti : gue, elo, dll.
- Berbicara dengan menggunakan intonasi suara yang sesuai, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat.
- Tidak membicarakan kejelekan atau kesalahan sesama karyawan baik yang dalam satu departemen ataupun berlainan departemen

3. Pada junior

- Berbicara dengan menggunakan kata-kata yang sopan, jelas, dan ramah.
- Berbicara dengan menggunakan intonasi suara yang sesuai, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat.
- Tidak membentak-bentak saat junior melakukan kesalahan

3.2.2 Etiket Berkomunikasi Secara Tidak Langsung

1. Tertulis
2. Telepon
 - Mulailah pembicaraan di telepon dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan ucapan siap membantu. Contoh : "selamat siang , dengan (nama) ada yang bisa saya bantu"
 - Gunakanlah kata-kata yang sopan, baik, dan jelas.
 - Usahakan untuk memberikan suasana yang akrab dengan menggunakan kata panggilan seperti Bapak, Ibu dll.
 - Dengarlah pembicaraan si penelepon dengan seksama, penuh perhatian, jangan memotong pembicaraan.
 - Jika ada yang menitip pesan, catatlah pesan-pesan penting yang disampaikan dan sampaikan pada orang yang bersangkutan.
 - Gunakanlah kata-kata "terima kasih" saat akan mengakhiri pembicaraan di telepon.
 - Tidak membiarkan telepon berdering lebih dari 3 kali.
 - Tidak membiarkan orang menunggu terlalu lama saat dalam menu "hold"
 - Dilarang menerima/menggunakan telepon untuk kepentingan pribadi.

Metode Berbicara Melalui Telepon antar PPA :

- Metode komunikasi saat menerima instruksi melalui telepon adalah : menulis – membacakan – konfirmasi kembali
- Menulis yang dimaksud adalah dilakukan di formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi untuk pasien lama dan pasien baru di form SBAR
- Format penulisan dengan menggunakan SOAP
- Membacakan dan konfirmasi kembali adalah menanyakan kembali kepada pemberi pesan dengan membacakan kembali pesan yang disampaikan dan apakah sudah sesuai dengan instruksi yang diberikan

3.2.3 Etiket saat menggunakan/berada di fasilitas umum

1. Lift
 - Dahulukan pasien, keluarga pasien, dokter, senior, atau pimpinan untuk menaiki lift saat lift sedang penuh
 - Usahakan untuk mempersilahkan pasien, keluarga pasien, dokter, senior, atau pimpinan untuk menaiki lift terlebih dahulu.
 - Jangan menyerobot/berebut saat akan menaiki lift.
 - Berusahalah untuk menyapa setiap orang yang ditemui didalam lift.
 - Jangan melakukan tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan pemakai lift yang lain seperti mengobrol, bercanda, tertawa, dll.
2. Koridor
 - Usahakan untuk menyapa setiap orang yang berpapasan di koridor rumah sakit
 - Tidak makan/minum di koridor rumah sakit
 - Tidak berhenti atau jalan bergerombol yang berakibat menghalangi akses orang lain.

3. Restoran/cafe

- Tidak bicara/mengobrol terlalu keras yang akan mengakibatkan orang lain terganggu
- Usahakan agar saat makan tidak berdecak.
- Jangan terlalu lama duduk di tempat makan yang akan mengakibatkan pengunjung lain yang ingin makan sulit mendapatkan tempat makan.

3.2.4 Etiket Dalam Masuk Ruang Perawatan

- Mengucapkan salam saat memasuki ruang perawatan pasien.
- Berusaha menunjukkan keramahan dan sikap empati terhadap pasien.
- Menanyakan kondisi pasien saat ditemui dan menawarkan bantuan apabila ada yang bisa dibantu.
- Mendengarkan keluhan pasien dengan seksama dan menindaklanjuti keluhan pasien.
- Mengucapkan salam perpisahan sebelum meninggalkan ruang perawatan.
- Tutup pintu setelah keluar dari ruang rawat inap.

3.2.5 Etiket saat Berada dalam Kamar Kecil

- Selalu berusaha menjaga kebersihan saat berada di kamar kecil
- Tidak merokok baik saat berada di kamar kecil ataupun saat berada di lingkungan rumah sakit.
- Tidak membuang pembalut atau barang-barang yang dapat menyumbat aliran air pembuangan di kamar kecil
- Tidak menggunakan fasilitas yang ada di kamar kecil secara berlebihan, contoh : tissue, sabun, dll

3.2.6 Etiket dalam Berpakaian

- Rambut harus selalu disisir dan ditata. Untuk rambut pendek tidak boleh melebihi bahu, sedangkan untuk rambut panjang harus diikat rapi
- Tidak menggunakan rias wajah / kosmetik yang terlalu mencolok
- Semua staf rumah sakit harus menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh manajemen rumah sakit
- Pakaian harus rapi, bersih, tidak kebesaran / kekecilan, dan baju harus dikancing rapih.
- Hindari bau badan dengan memakai wewangian, bedak, dll
- Tidak boleh menggunakan aksesoris yang berlebihan
- Penampilan secara keseluruhan harus mencerminkan keramahan dan kesopanan

3.3 Upaya untuk Mengatasi Hambatan Berkomunikasi

1. Petugas harus bersikap lembut dan sopan
2. Petugas lebih memaksimalkan volume suaranya khususnya untuk pasien yang mempunyai hambatan fisik dan lansia.
3. Apabila pasien atau keluarga pasien kurang memahami apabila menggunakan bahasa Indonesia maka petugas menyampaikan informasi dengan menggunakan bahasa daerah.
4. Mengoptimalkan panca inderanya (misal: gerakan tangan, gerakan mulut)
5. Untuk pasien tuna wicara biasanya membawa rekan untuk menerjemahkan ucapan yang disampaikan petugas rumah sakit.
6. Melakukan upaya :
 - a. Mengecek arti atau maksud yang disampaikan
Bertanya lebih lanjut kepada pasien/keluarga pasien apakah ia sudah mengerti apa yang dibicarakan.

Contoh: Petugas pendaftaran/Perawat bertanya pada pasien “Apakah sudah mengerti, Pak?”

-
- b. Meminta penjelasan lebih lanjut
Petugas lebih aktif berbicara untuk memastikan apakah ada hal lain yang perlu ditanyakan lagi.

Contoh: “Apa ada hal lain yang kurang jelas, Bu?”
 - c. Mengecek umpan balik atau hasil
Petugas memancing kembali dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal atau pesan yang telah disampaikan kepada pasien / keluarga pasien.

Contoh: “Tadi obatnya sudah diminum , Pak?”
 - d. Mengulangi pesan yang disampaikan memperkuat dengan bahasa isyarat
Contoh: “Obatnya diminum 3 kali sehari ya” sambil menggerakkan tangan.
 - e. Dokter atau perawat lebih mendekatkan diri dengan berbincang mengenai hal-hal yang menyangkut keluarga, keadaannya saat ini (keluhan tentang penyakitnya).
 - f. Membuat pesan secara singkat, jelas dan tepat
Petugas menyampaikan hanya hal-hal yang berhubungan pasien (atau yang ditanyakan pasien) sehingga lebih efisien dan tidak membuang-buang waktu.
7. Hambatan bahasa untuk pasien asing
- a. Apabila pasien membawa guide/penerjemah, maka informasi diberikan/ditanyakan melalui guide/penerjemah.
 - b. Apabila pasien tidak membawa penerjemah/guide, petugas memanggil karyawan yang mempunyai kemampuan.
 - c. Menggunakan penerjemah bagi pasien asing baik menggunakan guide maupun dengan cara melatih karyawan berbahasa inggris.
 - d. RS Prima Husada mempunyai perjanjian kerjasama dengan penerjemah bahasa (berlaku terhitung mulai tanggal 14 September 2018– 13 September 2020 :
 - Bahasa Inggris
 - Bahasa Madura

BAB IV PENUTUP

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Pedoman komunikasi efektif meliputi semua unit pelayanan , diantaranya unit rawat jalan, rawat inap, unit darurat, kamar operasi, unit layanan diagnostik, dan lainnya.

Pelaksana panduan ini adalah para tenaga kesehatan (medis, perawat, farmasi, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya); staf di ruang rawat, staf administratif, dan staf pendukung yang bekerja di rumah sakit. Semoga dengan adanya Pedoman Komunikasi Efektif ini, dapat meningkatkan komunikasi para profesional pemberi asuhan (PPA) yang efektif, tepat waktu, akurat, lengkap, tidak mendua (*ambiguous*), dan dapat diterima oleh penerima informasi yang bertujuan mengurangi kesalahan-kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 04 September 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah